

חלק ראשון - structured Q&A

מידע מאורגן לפי שאלות ותשובות

פרק 1: מידע רפואי אינפורמטיבי

שאלה מזה	נושא	שאלות נפוצות	תשובות	תגיות	תאריך עדכון
	אבחנה	מהי הפלה נדחית?	אובדן הריון מוקדם (early pregnancy loss) או הפלה נדחית (missed abortion) מוגדר כהריון לא ויאבילי בשליש הראשון. הגורם העיקרי הינו פגם גנטי נקודתית בהריון הספציפי, אשר מוביל להפסקתו בשלב מוקדם. בד"כ, הפגם הגנטי הוא ספציפי להריון הנוכחי, ואינו חור בהריונות הבאים.		
	אבחנה	כיצד מאבחנים הפלה נדחית	קריטריונים לאבחנה על פי אולטרסאונד : - הדגמת קוטב עוברי עם מדידת CRL של 7 מ"מ או יותר ללא דופק - הדגמת שק הריון בקוטר ממוצע של 25 מ"מ או יותר ללא קוטב עוברי - העדר דופק עוברי שבועיים או יותר לאחר הדגמת שק הריון שלא הודגם בו שק חלמון - העדר דופק עוברי 11 ימים או יותר לאחר הדגמת שק הריון עם שק חלמון - היעדר דופק עוברי בהריון שגילו 7.0 שבועות לפחות : - 3 שבועות או יותר לאחר בדיקת הריון חיובית (כמותית/איכותית)		

		- הריון IVF לפי חישוב גיל הריון			
		היות שמדובר באירוע שלא נוטה לחזור על עצמו, אין המלצה לבצע בירור מיוחד לאחר הפלה נדחית. במקרה של 3 הפלות אצל אותה המטופלת, מומלץ לבצע בירור של גורמים אחרים, כגון קרישיות יתר ומומים רחמיים. מומלץ להיוועץ ברופא המטפל או לפנות למרפאה המתמחה בטיפול בהפלות חוזרות.	האם יש צורך בבירור מיוחד לאחר הפלה	בירור	
5/11/2025	דימום, זמן התאוששות	צפוי דימום משמעותי של כ-3-4 ימים לאחר נטילת הציטוטקן ולאחר מכן ייתכן דימום קל אך ממושך למשך כשבועיים ולעיתים עד לוסת. הדימום הממושך הוא לרוב בכמות פחות מווסת. ייתכנו גם ימי הפסקה בדימום והישנות לאחר מכן במהלך פרק הזמן הזה.	כמה זמן דימום נחשב תקין?	דימום לאחר פרוצדורה	MED - 001
4/11/2025	תופעות לוואי, דימום	תופעות שכיחות: דימום המלווה בקרישי דם, כאבי בטן, התכווצויות, בחילות, לעיתים חום נמוך, רגישות בחזה, חולשה, גלי חום. תופעות חריגות המצריכות הערכה רפואית מיידי: חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד בלתי פוסק, דימום המצריך החלפת פד ספוג בתכיפות של מעל אחת לשעתיים, חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד יומיומי או סחרחורת משמעותית	אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?	תופעות לוואי	MED - 002
4/11/2025	סימפטומים, מיון	חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד בלתי פוסק, דימום המצריך החלפת פד ספוג בתכיפות של מעל אחת לשעתיים, חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד יומיומי או סחרחורת משמעותית, קושי בנשימה, כאבים שאינם מגיבים לתרופות לשיכוך כאב. איבוד הכרה.	איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידי?	מתי לפנות לרופא	MED - 003

5/11/2025	שיטות טיפול	קיימות שתי אפשרויות לטיפול בהפלה נדחית: תרופתית וניתוחית. השיטה התרופתית ניתנת לביצוע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, וכוללת נטילת תרופות, מפיג'ין וציטוטק, המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות. הפסקת הריון ניתוחית נקראית גם גרידה או שאיבה. זוהי פעולה שמבוצעת בחדר ניתוח יום בהרדמה מלאה במהלכה נעשה שימוש במכשירים כירורגיים בהנחיית אולטרסאונד לרוקן את תוכן הרחם.	אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון?	מתי לפנות לרופא	MED - 004
5/11/2025	הפסקה תרופתית, שבוע 9, תרופות	תהליך המבוצע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, כולל נטילת תרופות המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות.	מהו טיפול תרופתי להפלה נדחית?	הגדרת הפסקה תרופתית	MED - 005
5/11/2025	ביקור ראשון, הטיפול התרופתי	מפגש עם רופא, סקירת רקע רפואי, וידוא שאין התוויות נגד, בליעת כדור מפיג'ין (mifepristone 200 mg). השגחה של 20 דקות וזיהוי של תגובה אלרגית במידה ומתפתחת.	מה קורה בביקור הראשון?	ביקור ראשון	MED - 006
5/11/2025	ביקור ראשון, הטיפול התרופתי	במקרים הבאים הרופא ימליץ לך להימנע מהפסקת הריון תרופתית: הריון מעל שבוע 12+0 על פי אולטרסאונד, אנמיה קשה (המוגלובין > 9), הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה, מחלת כבד פעילה, מחלה קרדיווסקולרית, אפילפסיה לא מאוזנת, אסטמה, חשד להריון חוץ-רחמי או הריון בצלקת של ניתוח קיסרי, אלרגיה לאחת התרופות שניתנות בטיפול, אי-יכולת לעמוד במעקב או הוראות טיפול	באיזה מקרים לא ניתן לבצע טיפול תרופתי? מהן התוויות הנגד?	ביקור ראשון	MED - 007
5/11/2025	הכנה, אישורים, סונר	מכתב הפניה מהרופא אשר מתעד את האבחנה של הפלה נדחית, תוצאות בדיקות דם מהחודש האחרון כולל ספירת דם וסוג דם,	מה להביא לביקור הראשון?	הכנות לביקור ראשון	MED - 008

5/11/2025	ביקור ראשון, הטיפול התרופתי	בעת הגעתך למתחם מרפאות נשים בבית החולים וולפסון תתקבלי ע"י המזכירות ולאחר הצגת טופס 17 או פיקדון, הן יפתחו לך תיק ממוחשב ויוציאו מדבקות. עם המדבקות את תתקבלי ע"י האחות שתרזז את כל המסמכים ותבצע בדיקה של לחץ דם ודופק. האחות תעביר אותך לרופאה שתעבור על המסמכים, תמלא את הפרטים במחשב, תסביר על התהליך ולאחר מענה על שאלות תחתים אותך על טפסי הסכמה לתהליך המפרטים את התהליך, הסיכונים והסיכונים האפשריים. בסיום המפגש תקבלי כדור מפיג'ין אותו עלייך ליטול בחדר הרופאה ובנוסף תצויידי במעטפה בתוכה עוד ארבעה כדורי ציטוטק אותם יש להניח בנרתיק, בבית, כעבור 48 שעות. לאחר נטילת הכדור במרפאה תתבקשי לחכות 20 דקות בחדר ההמתנה בהן תקבעי תור לביקורת במרפאה.	כמה זמן נמשך הביקור? מה קורה בביקור הראשון בהרחבה?	ביקור ראשון	MED - 009
	תופעות לוואי, מפיג'ין, דימום	ברוב המקרים תחושי בחילה (לעיתים כמו בהריון צעיר), לעיתים דימום קל, כאבים קלים.	אילו תופעות צפויות אחרי נטילת מפיג'ין? אילו תופעות צפויות אחרי הביקור הראשון?	תופעות אחרי מפיג'ין	MED - 010
5/11/2025	ציטוטק, כאבים, דימום	בסיום המפגש הרופאה תצייד אותך במעטפה ובה ארבעה כדורי ציטוטק (Misoprostol) אותם תתבקשי להניח בנרתיק (עמוק ככל שניתן), בבית, כעבור 48 שעות ממועד נטילת המפיג'ין. כדורים אלה גורמים להתכווצויות רחם וריקון תוכן ההריון. בנוסף תיתכן חולשה, עליית חום קלה, צמרמורות, בחילות.	מה השלב השני? מהו הטיפול בציטוטק?	שלב שני: ציטוטק	MED - 011

28/12/2025	בחילות, ציטוטק, מפיג'ין	אין חשיבות למועד נטילת התרופות, אין מניעה לקחת עם או בלי אוכל. במידה ואת מרגישה בחילות טרם תחילת הטיפול מומלץ ליטול כדור נגד בחילות שיכול להנתן לך במרפאה טרם הטיפול על מנת למנוע הקאה של הכדורים. יש להקפיד על הפרש של 48 שעות בין החלק הראשון של נטילת המפיג'ין לחלק השני של נטילת הציטוטק.	האם יש ליטול את הטיפול עם או בלי אוכל?	תרופות	MED - 012
28/12/2025	ציטוטק, כאבים, דימום	נצפה לראות קרישי דם, וגושים הדומים ל"כבד" וכן נצפה לכאבים חזקים והתכווצויות בבטן תחתונה. רוב הנשים מתארות כאבים אלו ככאבים משמעותיים יותר מכאבי מחזור.	מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?	תופעות גופניות	MED - 013
28/12/2025	דימום רציף, דימום מקוטע	הדימום יכול להיות דימום רציף וממושך למשך מספר ימים, ולחילופין הדימום יכול להיעצר ולהתחדש אחרי מספר שעות/ימים. כל עוד לא מדובר בדימום זורם כמו "ברז" או צורך בהחלפת מעל פד בשעתיים – מדובר בדימום תקין.	האם יש הבדל בין דימום רציף לדימום שבא והולך? האם הדימום אמור להיעלם בהדרגה או בפתאומיות?	שלב הדימום	MED - 014
5/11/2025	קרישי דם, דימום	אצל כל אישה דימום הוא בעל אופי שונה. אצל מרבית הנשים נצפה לראות קרישי דם או רקמה הריונית הנפלטת במהלך התהליך, אך ייתכן תהליך תקין גם ללא יציאה של קרישי דם.	האם קרישי דם הם תמיד חלק מהתהליך?	שלב הדימום	MED - 015
5/11/2025	מפיג'ין, ציטוטק, תרופות	מפיג'ין: תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים. ציטוטק: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C , צמרמורות. שכיחות: בחילה (43%-66%), שלשול (23%-35%), כאב ראש (13%-40%), חום/צמרמורות (32%-69%).	מהן תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי? מה השכיחות שלהן?	תרופות	MED - 016
28/12/2025	חום, תסמינים, שכיח	חום נמוך הוא תופעה יחסית שכיחה המופיעה אצל 30%-70 מהמטופלות. במידה ומדובר בחום מעל 39 מעלות או חום שאינו מגיב לתרופות להורדת חום – יש לפנות לבדיקת רופא זמינה במייד.	האם חום נמוך הוא תופעה שכיחה?	תופעות גופניות	MED - 017

28/12/2025	ציטוטק, כאבים, תזמון	אצל מרבית הנשים התהליך הכולל דימום משמעותי וכאבים עזים יתחיל לאחר נטילת כדורי הציטוטק בבית. לרוב נצפה לתגובה תוך חצי שעה ועד ליממה. ייתכנו מקרים בהם התגובה תתחיל כבר לאחר נטילת המפיג'ין במרפאה או לחילופין מקרים בהם התגובה מתחילה רק במהלך השבוע שלאחר נטילת הציטוטק.	ממתי לקחת ימי מחלה? מתי הכל יתחיל? מתי יתחיל החלק העיקרי של התהליך?	תחילת התהליך	MED - 018
5/11/2025	התאוששו ת, החלמה, זמן	בדרך כלל מדובר על 3-4 ימים של אי נוחות, כאבים עזים ודימום משמעותי. אחר כך רוב הנשים חוות הטבה משמעותית, אך דימום קל וכאבים יכולים להימשך עד שבועיים ולעיתים עד הוסת.	כמה זמן לא מרגישים טוב? ומה קורה אחר-כך? כמה זמן נמשך השלב הלא נוח?	משך ההחלמה	MED - 019
28/12/2025	משככי כאבים, המלצות	כן, כל משכך כאבים שעוזר בזמן מחזור מתאים גם כאן (לדוגמה: נורופן, אדוויל, אקמול, אופטלגין). יש להקפיד על הוראות רוקח.	האם מותר לקחת משככי כאבים? האם מותר לשלב בין משככי כאבים?	משככי כאבים	MED - 020
5/11/2025	משככי כאבים, המלצות	ניתן לקחת משככי כאבים כהכנה, אך הדבר תלוי בהעדפתך. חלק מהנשים מעדיפות לחכות עד שמתחילים הכאבים ואז ליטול משכך. בכל מקרה, חשוב שיהיו משככי כאבים זמינים למקרה הצורך, ותמיד להקפיד על המינון והנחיות הרוקח.	האם מומלץ לקחת משככי כאבים לפני תחילת הטיפול או רק כשמופיעים הכאבים?	משככי כאבים	MED - 021

28/12/2025	מפיג'ין, ציטוטק, תרופות	הטיפול מורכב גם ממפיג'ין (Mifepristone) ולא רק מציטוטק (Misoprostol) כי שילוב התרופות משפר משמעותית את יעילות ההפסקה התרופתית לעומת שימוש בציטוטק בלבד, ומפחית את שיעורי הכישלון והצורך בהתערבות ניתוחית. טיפול משולב הוא הסטנדרט במרבית מדינות ומרכזים רפואיים, ורק במקרים מסוימים יש אפשרות לשימוש בלעדי בציטוטק כאשר נחוץ. יתרונות השילוב: 1. שיעורי הצלחה של מעל 95%-98% להשלמת הפסקת ההריון בשבועות המוקדמים. 2. פחות מקרים של המשך הריון/שאריית ברחם לעומת טיפול בציטוטק בלבד. 3. פחות צורך בכירורגיה משלימה (גרידה).	מדוע הטיפול מורכב ממפיג'ין וציטוטק? חברה סיפרה לי שהיא קיבלה רק סוג אחד של כדור.	תרופות	MED - 022
28/12/2025	מפיג'ין, ציטוטק	אפשרי להשתמש בציטוטק בלבד, אך יעילות ההליך יורדת (שיעור כישלון עולה לכ-10%-15%).	מה לעשות אם אין מפיג'ין? מה לעשות אם אני אלרגית למפיג'ין?	תרופות	MED - 023
28/12/2025	מפיג'ין, תרופות	מפיג'ין (Mifepristone) הוא אנטי-פרוגסטרון החוסם את השפעת הפרוגסטרון ברחם, ההורמון החיוני להמשך ההריון. בכך המפיג'ין מחליש את רירית הרחם ומגביר את רגישות הרחם לפרוסטגלנדינים, כלומר מגביר את ההשפעה המרוקנת של ציטוטק. לאחר נטילת מפיג'ין ייתכנו תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים.	מה זה מפיג'ין? מה תופעות הלוואי של מפיג'ין?	תרופות	MED - 024
28/12/2025	ציטוטק, תרופות	ציטוטק (Misoprostol) הוא פרוסטגלנדין שגורם להתכווצויות רחם ופינוי פיזי של תוכן ההריון. תופעות הלוואי של ציטוטק כוללות: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C , צמרמורות.	מה זה ציטוטק?	תרופות	MED - 025
5/11/2025	סימני הצלחה, ריקון רחם	בעת סיום הביקור הראשון נתאם לך תור לביקורת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק. במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד בגישה נרתיקית לוודא שהרחם התרוקן ואין שאריות הריון. אם יש שארית ברחם – יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק, או גרידה ניתוחית, על פי רצונך והמלצת הרופא).	איך אדע שהטיפול הצליח? האם נדרש מעקב? איך אני עושה ביקורת?	ביקורת	MED - 026

		במידה וקיבלת מנה נוספת של ציטוטק, תוזמני לביקור נוספת כעבור שבוע. במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד בגישה נרתיקית לוודא שהרחם התרוקן ואין שאריות הריון. אם יש שארית ברחם – ההמלצה תהיה לבצע גרידה	מה קורה בביקורת השנייה	ביקורת שנייה	
5/11/2025	יחסי מין, פעילות, אלכוהול	במהלך הטיפול אנו ממליצים להימנע מקיום יחסי מין, כניסה לים ולבריכה, פעילות גופנית מאומצת ושתיית אלכוהול. עם סיום דימום ותחושת רווחה ניתן לחזור לפעילות שגרתית, לרוב תוך 3-4 ימים לאחר ציטוטק. לפעילות הכוללת כניסה לים/בריכה וקיום יחסים יש להמתין עד להשלמת הביקורת כעבור שבועיים.	האם ישנן הגבלות בזמן הטיפול? מהן? לכמה זמן?	מהלך הטיפול	MED - 027
28/12/2025	פעילות רגילה, ספורט, החלמה	עם סיום דימום ותחושת רווחה ניתן לחזור לפעילות שגרתית, לרוב תוך 3-4 ימים לאחר ציטוטק. בזמן הזה אפשר גם לחזור לפעילות ספורטיבית שגרתית כל עוד את מרגישה טוב וללא סחרחורות או תחושת עילפון. במידה ואינך בטוחה מומלץ לפנות לרופא זמין לקבלת מענה אישי עבור מצבך.	מתי אפשר לחזור לפעילות רגילה?	חזרה לשגרה	MED - 028
5/11/2025	דימום, פעילות גופנית, מאמץ	תיתכן התגברות בדימום כתוצאה מפעילות מאומצת או שינוי תנוחה – תופעה תקינה. במידה ומופיע דימום מוגבר לאחר פעילות, יש לפנות לבדיקת רופא במייד.	מה אם בזמן פעילות גופנית קלה אני שמה לב שהדימום מתגבר? האם זה נורמלי?	חזרה לשגרה	MED - 029
28/12/2025	יחסי מין, אמצעי מניעה	מומלץ להמתין עד לאחר הביקורת ולאחר ייעוץ עם רופא. שימי לב שעוד במהלך ההליך, טרם הביקורת, קיים סיכוי להריון נוסף בעת קיום יחסים לא מוגנים – יש להקפיד על אמצעי מניעה.	מתי אפשר לחזור לקיים יחסי מין?	יחסי מין	MED - 030

5/11/2025	אלכוהול, קנאביס	מומלץ להימנע משימוש בסמים ואלכוהול עד להשלמת כל התהליך וביקורת תקינה.	האם מותר לשתות אלכוהול במהלך הטיפול? האם מותר לצרוך קנאביס במהלך הטיפול?	שימוש בסמים ואלכוהול	MED - 031
28/12/2025	שארית, גרידה, ציטוטק	שארית היא חלק מרקמה הריונית שאינה עובר או שק הריון. אם יש שארית ברחם - יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק, או גרידה ניתוחית).	מהי שארית? מה עושים אם יש שארית?	סיבוכים	MED - 032
28/12/2025	סיום התהליך, וסת	התהליך מושלם לחלוטין לאחר הוסת הראשונה, המעידה על חזרה של הפעילות ההורמונלית השגרתית שלך.	מתי הגוף מפסיק להיות בתהליך?	סיום התהליך	MED - 033
28/12/2025	טמפונים, פדים, זיהום	ההמלצה הרפואית היא שימוש בפדים בלבד, ללא שימוש בטמפונים. הפדים מאפשרים מעקב אחר כמות הדימום והפחתת הסיכון לזיהום.	האם מותר להשתמש בטמפונים או רק בפדים?	היגיינה	MED - 034
28/12/2025	שארית, ביקורת	לעיתים ישנה שארית קטנה אשר לא ניתנת לזיהוי בסונר מיד בסיום התהליך. הבדיקה המיטבית נעשית מיד בסיום הוסת.	למה אני צריכה ללכת לרופא נשים שלי לאחר הוסת?	ביקורת	MED - 035
5/11/2025	יעילות, ללא ניתוח, בבית	נמנעת פעולה פולשנית בהרדמה כללית. תהליך שיכול להתבצע בבית, בסביבה הנוחה והפרטית שלך. ללא השפעה על פוריות עתידית.	יתרונות הטיפול התרופתי?	יתרונות הטיפול התרופתי	MED - 036
28/12/2025	ביקורת, גרידה	אם בביקורת הרופאה תקבע שיש צורך בהתערבות ניתוחית - תופני למזכירת המרפאה לתיאום התור.	איך קובעים גרידה?	ביקורת	MED - 037
5/11/2025	כישלון, שארית, התערבות ניתוחית	כישלון, שארית, התערבות ניתוחית. הטיפול דורש כמה ביקורים ויכול להימשך מספר שבועות. צפוי כאב ודימום משמעותי במשך מספר ימים.	מה החסרונות של הטיפול התרופתי?	חסרונות הטיפול התרופתי	MED - 038

28/12/2025	כישלון, שארית, התערבות ניתוחית	בכ-5%-10% מהמקרים נצפית שארית בביקורת, המצריכה השלמת פעולה ניתוחית.	מה הסיכוי שאצטרך התערבות ניתוחית לאחר הטיפול?	סיבוכים	MED - 039
28/12/2025	טיפול נוסף, חיזוי, תגובה	לא ניתן לצפות מראש אם יהיה צורך בטיפול נוסף – כל אישה מגיבה שונה לטיפול התרופתי, ואין אמצעים לנבא את התגובה.	האם ניתן לצפות מראש אם יהיה צורך בטיפול נוסף?	סיבוכים	MED - 040
28/12/2025	היערכות, הכנות, בבית	תהיי מוכנה מראש ל-3-5 ימי מחלה בבית. מומלץ בנוסף להצטייד במשככי כאבים ובפדים עבים (כדוגמת פדים לאחר לידה). מומלץ לדאוג לליווי של אדם קרוב (משפחה או חברים).	איך להיערך לטיפול?	הכנות	MED - 041
6/11/2025	סיכונים, בטיחות	כן. הטיפול התרופתי בטוח מאוד, ומבוצע תחת השגחה וניטור רפואי – רוב המטופלות עוברות את ההליך בהצלחה. פחות מ-1% מהפסקות ההריון מצריכות פנייה דחופה למיון.	האם הטיפול בטוח? האם יש פגיעה לאם או לעובר הבא?	בטיחות	MED - 042
6/11/2025	סימפטומי ם, חירום, מיון	אם את חווה אחד או יותר מהסימפטומים הבאים, עליך לגשת מיד לבדיקה רפואית: דימום כבד ביותר ("ברז" – יותר משתי תחבושות גדולות בשעה לשעתיים רצופות), חום מעל 38 מעלות צלזיוס שאינו מגיב לטיפול במשככי כאבים, הקאות שאינן נפסקות, כאבי בטן חמורים שאינם מגיבים למשככי כאבים, חולשה קיצונית או התעלפות.	מתי לפנות דחוף לרופא?	מתי לפנות לרופא	MED - 043
28/12/2025	ביקורת, מעקב, חובה	כן, חשוב מאוד לבצע את הביקורת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק, על מנת לוודא שההרחם התרוקן באופן מלא ואין שאריות. הביקורת חיונית כדי למנוע סיבוכים אפשריים כמו זיהום עקב שארית הריונית.	האם אני חייבת להגיע לביקורת?	ביקורת	MED - 045

28/12/2025	ביקורת, קופת חולים	ברוב המקרים, כן – אפשר לבצע את בדיקת הביקורת (אולטרסאונד) גם בקופת החולים, בתנאי שיש לרופא הנשים שלך אולטרסאונד זמין. חשוב לוודא עם הרופא/ה המטפל/ת אם היא/הוא מנוסים בזיהוי תוצאות הטיפול התרופתי.	האם ניתן לבצע ביקורת במסגרת קופת חולים?	ביקורת	MED - 046
6/11/2025	ביקורת, פספוס	במקרה של פספוס הביקורת המתוכננת, חשוב לקבוע מועד חדש בהקדם האפשרי. יש ליצור קשר עם המרפאה וליידע אותם על הפספוס כדי שיתאמו לך תור חדש בהקדם. בינתיים, יש לשים לב לסימפטומים חריגים (כגון דימום כבד מאוד או חום גבוה) ובמקרה הצורך לפנות לרופא.	מה לעשות במידה ופספסתי את הביקורת?	ביקורת	MED - 047
6/11/2025	סימני הצלחה, ריקון רחם	סימן עיקרי להצלחת ההליך הוא הפסקת הדימום הכבד וחזרה הדרגתית לדימום קל ולאחר מכן להפסקת דימום מלאה. בנוסף, ייתכן שתרגישי שיפור בהרגשה הכללית (פחות כאבים והתכווציות). עם זאת, הדרך היחידה לוודא שהרחם התרוקן היא באמצעות בדיקת אולטרסאונד בביקורת.	האם יש סימנים גופניים לכך שהרחם התרוקן?	סימני הצלחה	MED - 048
28/12/2025	הקאה, ספיגה, כדור	אם הקאת בתוך פחות משעתיים מנטילת הכדור, ייתכן שהתרופה לא נספגה במלואה. יש ליצור קשר עם המרפאה בהקדם – במקרים מסוימים ייתכן שימליצו לך על מנה נוספת. אם ההקאה התרחשה לאחר יותר משעתיים, סביר להניח שהכדור נספג, ואין צורך לחזור על המנה.	מה קורה אם הקאתי לאחר נטילת הכדור?	הקאה	MED - 049
28/12/2025	אנטיביוטיק ה, זיהום, מניעה	באופן שגרתי, לאחר הפסקת הריון תרופתית אין צורך באנטיביוטיקה מונעת. אנטיביוטיקה תינתן רק אם עולה חשד לזיהום (למשל, במקרה של חום גבוה או הפרשות בעלות ריח רע), לפי שיקול דעת רפואי.	האם אני צריכה לקחת אנטיביוטיקה?	אנטיביוטיקה	MED - 050
28/12/2025	וסת, מחזור ראשון	הווסת הראשונה תגיע בדרך כלל 4–6 שבועות לאחר ההליך. חשוב לזכור שהגוף צריך זמן להתאזן הורמונלית אחרי הפסקת ההריון. אם אין וסת תוך 6 שבועות, כדאי לפנות לרופא לבדיקה.	מתי יגיע הוסת? מתי צפוי המחזור הראשון?	וסת ראשונה	MED - 051

6/11/2025	הריון הבא	ניתן להתחיל לנסות להרות פעם נוספת לאחר הוסת הראשון, שמגיע לרוב בתוך כ-3-4 שבועות מתחילת הטיפול	מתי אפשר לנסות להיכנס להריון נוסף	פוריות עתידית	MED - 052
28/12/2025	פוריות, הריונות עתידיים	אין הוכחות שטיפול הפסקת הריון תרופתית מעלה את השכיחות של הריון חוץ-רחמי בעתיד. כמו כן, לא נמצא קשר בין הטיפול התרופתי לסיבוכים בהריונות עתידיים – ברוב המקרים, הריונות עתידיים מתנהלים בצורה תקינה.	האם בעקבות הטיפול יש סכנה להריון חוץ רחמי? מה הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים?	פוריות עתידית	MED - 053
6/11/2025	פוריות, מחזור, תסמונת קדם-וסתית	הטיפול התרופתי נחשב בטוח ואינו ידוע כמשפיע לרעה על פוריות עתידית, על סדירות הווסת או על הופעת תסמונת קדם-וסתית. לרוב, לאחר הפסקת הריון תרופתית, המחזור החודשי יחזור לסדרו תוך חודשיים-שלושה.	האם הטיפול התרופתי יכול לסכן אותי בעתיד? מבחינת פריה, וסת או תסמונת קדם וסתית	פוריות עתידית	MED - 054
6/11/2025	הריון חוץ-רחמי, מפיג'ין, ציטוטק	לא – הטיפול התרופתי מיועד להפסקת הריון תוך-רחמי בלבד. בהריון חוץ-רחמי יש צורך בטיפול רפואי אחר (לרוב, תרופה בשם מתוטרקסט או ניתוח), כיוון שהריון חוץ-רחמי אינו יכול להתפתח בצורה תקינה ודורש התערבות.	האם הטיפול במפיג'ין וציטוטק מתאים גם להריון חוץ רחמי?	הריון חוץ-רחמי	MED - 055
28/12/2025	Rh, סוג דם, שלילי	סוג הדם חשוב כדי לקבוע אם יש צורך במתן זריקת אנטי-D. במקרה שיש לך סוג דם עם RH שלילי, ויתברר בייעוץ או בבדיקה שהעובר עם RH חיובי – תצטרכי לקבל זריקת אנטי-D לאחר ההליך כדי למנוע בעיות בהריונות עתידיים.	למה משמש סוג הדם שלי? מה המשמעות של סוג דם שלילי (RH NEG)?	סוג דם	MED - 056
6/11/2025	הנקה, תרופות	במהלך הטיפול התרופתי ובהמשך התהליך אפשר להמשיך בהנקה, אך כדאי להתייעץ עם רופא לגבי תזמון נטילת התרופות ביחס להנקה. לעיתים מומלץ להניק ואז לקחת את התרופה, או לשאוב חלב מראש, כדי למנוע חשיפה של התינוק לכמות גדולה של התרופה דרך החלב.	אני מניקה, האם ניתן להמשיך להניק?	הנקה	MED - 057

28/12/2025	גרידה, שאיבה, ניתוח	הפסקת הריון ניתוחית הנקראית גם גרידה או שאיבה היא פעולה פולשנית המבוצעת בחדר ניתוח יום בהרדמה מלאה. במהלך הגרידה ולאחר שאת נרדמת הרופא, תחת בקרת אולטראסאונד, ישאב את כל התוכן ההריוני מחלל הרחם. מעצם היותה פעולה פולשנית זוהי פעולה שכרוכה בסיבוכים כולל זיהום ברחם, דימום המצריך התערבות ניתוחית או תרופתית נוספת ופגיעה ברחם היכולה להוביל לאי פריון עתידי. חשוב להדגיש ששיעור הסיבוכים לאחר גרידה הם נמוכים ביותר.	מהי גרידה? מהי שאיבה?	טיפול ניתוחי	MED - 058
28/12/2025	ליווי, תמיכה	מומלץ להגיע עם מלווה תומך לביקור הראשון ולהליך עצמו, שכן ייתכן שלא תרגישי במיטבך אחרי נטילת התרופות (עקב כאבים או חולשה). המלווה יכול לסייע לך לחזור הביתה בבטחה ולספק תמיכה רגשית.	האם צריך להגיע עם מלווה?	מלווה	MED - 059
28/12/2025	ימי מחלה, מנוחה	אנו ממליצים על 3 ימי מחלה החל מנטילת הציטוטק, עם זאת יש לפנות לרופא בקופת החולים לצורך קבלת ימי מחלה תקפים.	האם אקבל ימי מחלה?	ימי מחלה	MED - 060
28/12/2025	דיסקרטי, סודיות, תיק רפואי	ישנה אפשרות לשמור את הטיפול בגיליון חסוי, כך שהמידע יישמר רק בארכיון בית החולים ולא תהיה אפשרות לגשת אליו – לא לעובדי בית החולים ולא לרופאים בקהילה.	האם הטיפול תועד בתיק הרפואי שלי? האם זה דיסקרטי?	חסיון רפואי	MED - 061
28/12/2025	אולטראסא ונד, ועדה	יש צורך לוודא את האבחנה של הפלה נדחית לפני תחילת הטיפול כדי למנוע מצב בו תקבלי טיפול להספקת הריון במקרה של הריון תקין. במידה ולא קיימת אבחנה ודאית, תתבקשי לעבור הערכה חוזרת טרם תחילת הטיפול. את ההערכה ניתן לבצע גם בעת הביקור הראשון במרפאה.	מדוע עליי להביא מכתב מהרופא?	הפניה מרופא	MED - 062

28/12/2025	עלות, תשלום, התחייבות כספית	הטיפול כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים או גורם מבטח אחר.	האם הטיפול להפסקת הריון עולה כסף?	עלויות	MED - 072
28/12/2025	טופס 17, קופת חולים	קופת חולים מכבי: לרוב לא נדרש טופס 17; קופות אחרות (כללית/מאוחדת/לאומית): נדרש טופס 17 בכל מקרה.	האם אני צריכה להביא טופס 17 לטיפול?	עלויות	MED - 073
28/12/2025	עלות, מחיר, משרד הבריאות	במידה וקופת החולים אינה מספקת לך טופס 17 להפסקת הריון ישנה אפשרות לשלם באופן פרטי על התהליך, עלות הטיפול בהפלה נדחית משתנה בהתאם לסוג הטיפול. תעריפי הטיפול מפורסמים באתר של משרד הבריאות	מה העלות של טיפול בהפלה נדחית?	עלויות	MED - 074
28/12/2025	עלות, מחיר, משרד הבריאות	לרוב, כל מקרה של טיפול בהפלה נדחית ממומן על ידי קופת החולים ו/או משרד הביטחון (במקרה של חיילות). עדיף לברר באופן ישיר מול הגורם המבטח.	האם אני זכאית למימון של הטיפול?	עלויות	MED - 075

02/01/2025	אבחון הריון, וסת אחרונה	הסימן המוקדם והאמין ביותר להריון הוא איחור במחזור החודשי. אם קיימת יחסי מין ושמת לב שהדימום החודשי שלך מאחר, ייתכן שאת בהריון. סימנים נפוצים נוספים להריון כוללים בחילות, כאב ראש, תחושת עייפות ושדיים מוגדלים ורגישות. אם יש לך אחד מהתסמינים הללו, בנוסף למחזור חודשי שאינך מקבל, יש סיכוי טוב שאת בהריון. אם את חושבת שאת בהריון, את יכולה לאשר זאת על ידי ביצוע בדיקת הריון בשתן. בדיקות הריון נמכרות בדרך כלל בבתי מרקחת ובחנויות נוחות, או שאת יכולה לפנות למרכז רפואי כדי לקבל אחת.	איך אני יודעת שאני בהריון?	אבחון הריון	MED - 076
02/01/2025	אבחון הריון, וסת אחרונה	את שבוע ההריון נהוג לחשב מהיום שבו התחילה הוסת האחרונה. ספרי את מספר השבועות והימים מאותו יום ועד לתאריך היום. זהו מספר השבועות והימים של ההריון שלך. אם אינך בטוחה מתי הייתה המחזור החודשי האחרון שלך, תוכלי גם לפנות למרפאה שלך ולעבור בדיקת אולטרסאונד וגינאלי כדי להעריך כמה שבועות את בהריון. במקרה של הפלה נדחית מחושב גיל ההריון בשני האופנים: גם לפי תאריך וסת אחרון וגם לפי אולטרסאונד.	איך אני יודעת מה שבוע ההריון שלי? באיזה חודש אני?	אבחון הריון	MED - 077
02/01/2025	הפלה נדחית, הלה ספונטנית, היעדר דופק	ישנן סיבות שונות להיעדר דופק בעובר. במידה וטרם ניצפה דופק בהריון הנוכחי יתכן ומדובר בהריון צעיר ועדין לא ניתן להבחין בדופק בבדיקת אולטרסאונד. במקרה כזה, במידה ונצפה שק הריון תוך רחמי ברור אין צורך להמתין להופעת דופק טרם ביצוע הפסקת הריון תרופתית. לעומת זאת, במידה ונצפה בעבר דופק לעובר בהריון הנוכחי או שנאמר לך שמדובר בהריון לא תקין/ הפלה נדחית כבר אין מדובר במצב של הפסקת הריון יזומה אלא במצב של הפלה ועל כן הטיפול שונה במעט. במידה ואת חשה בטוב, ללא דימום משמעותי, חום או כאבים עזים מאוד מומלץ לגשת לרופא נשים שלך בהקדם, למיון עם הפניה מתאימה או למרפאה שלנו בליווי טופס 17 מתאים לצורך הסבר על אפשרויות הטיפול השונות והמשך ההליך.	העובר שלי ללא דופק	הפלה ספונטנית	MED - 078

02/01/2025	שינוי טיפול	ניתן, בכל שלב של הטיפול התרופתי בהפלה נדחית, לבחור לסיים את הטיפול בגרידה	התחלתי טיפול תרופתי והתחרטתי	המשך ההריון	MED - 079
------------	-------------	---	------------------------------	-------------	-----------

פרק 2: תמיכה רגשית

מזהה	מצב רגשי	ביטוי מטופלת	תגובה אמפתית	שאלות להמשך	פעולה מוצעת	דגל
EMO-001	מצוקה מתמשכת	"מצב הרוח שלי לא משתפר, אני מרגישה ככה כבר הרבה זמן"	ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עליך.		הפניה לעזרה מתחום בריאות הנפש - דרך רופא משפחה, עובדת סוציאלית, פסיכולוג בקופת החולים, באופן פרטי או במסגרת המרפאה במרכז הרפואי וולפסון.	אדום
EMO-002	מצוקה מתמשכת	"עברו כמה שבועות ואני לא מרגישה הקלה"				אדום
EMO-003	פגיעה בתפקוד	"קשה לי לתפקד ביום-יום"	בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש, כדי לקבל תמיכה ולהקל על ההתמודדות.			אדום
EMO-004	פגיעה בתפקוד	"אפילו דברים קטנים מרגישים לי בלתי אפשריים"				אדום
EMO-005	הצפה רגשית	"אני מרגישה מוצפת כמעט כל הזמן"				אדום
EMO-006	הפרעות שינה	"אני כמעט לא ישנה בלילה כבר הרבה זמן"				אדום
EMO-007	הפרעות תפקוד	"אני לא מצליחה להתרכז בשום דבר"	פנייה לפסיכולוגית, עובדת סוציאלית			אדום

אדום			או גורם טיפולי אחר היא צעד מקובל ונכון במצבים כאלה, ואינה מעידה על חולשה או בעיה אצלך.	"אני מרגישה לבד לגמרי"	בדידות	EMO-008
אדום				"אני מרגישה שאני צריכה עזרה אבל לא יודעת ממי"	צורך בעזרה	EMO-009
אדום			אפשר להתחיל דרך קופת החולים או דרך גורם מקצועי פרטי, אפילו בשיחה אחת בלבד.	"אני לא מסתדרת עם זה לבד"	עומס רגשי	EMO-010

מזהה	נושא	שאלה נפוצה	תשובה כללית	תגיות	סימון דגלים	תאריך עדכון
EMO-011	עצב	זה נורמלי שאני מרגישה כל כך עצובה ובוכה הרבה אחרי ההפלה?	כן, זה טבעי להרגיש עצב עמוק אחרי נדחית. הרבה נשים בוכות ומרגישות דכדוך בתקופה הזאת. בדרך כלל העצב החזק נחלש בהדרגה ככל שעובר הזמן.	עצב, בכי, אבל	דגל ירוק	דצמבר 2025
EMO-012	רגשות אשם וחרטה	אני מרגישה רגשות אשם ומתחרטת על ההחלטה. האם התחושות האלה רגילות?	תחושות אשמה וחרטה נפוצות מאוד אחרי הפלה נדחית, אפילו אם היית משוכנעת שזה הצעד הנכון. לגמרי נורמלי להרגיש אשמה או לתהות אם עשית נכון, והרבה נשים מזדהות עם זה. עם הזמן, רוב הנשים לומדות לקבל את ההחלטה שלהן והרגשות הקשים נרגעים.	אשמה, חרטה, החלטה	דגל אדום	דצמבר 2025
EMO-013	בדידות	אף אחד לא יודע על ההפלה שלי ואני מרגישה מאוד לבד. זה נורמלי להרגיש ככה?	בהחלט מובן להרגיש בדידות כשאת שומרת דבר כזה לעצמך. נשים רבות לא משתפות ומרגישות שאף אחד לא יכול להבין אותן. את לא היחידה שמרגישה לבד במצב הזה – התחושה נפוצה, ולפעמים הידיעה שיש אחרות שמרגישות כך יכולה לעזור מעט. את יכולה לנסות לפנות לחברה קרובה או קרובת משפחה ולשתף. תראי שבמהרה תמצאי עוד נשים שעברו אותו הדבר.	בדידות, תמיכה, סודיות	דגל אדום	דצמבר 2025

דצמבר 2025	דגל ירוק	חרדה, פוריות, עתיד	כן, חשש לגבי פוריות עתידית אחרי הפסקת הריון הוא נפוץ מאוד. הרבה נשים דואגות כמוך, אבל לרוב טיפול בהפלה נדחית לא פוגע ביכולת שלהן להיכנס להריון בעתיד. הגוף מתאושש די מהר, ואין השפעה ארוכת טווח על הפוריות.	אני דואגת שההפלה פגעה לי בסיכוי להרות בעתיד. האם זה חשש נפוץ?	חרדה	EMO-014
דצמבר 2025	דגל ירוק	כעס, קנאה, תסכול	כן, תחושות של כעס ואפילו קנאה הן טבעיות במצב כזה. הרבה נשים מרגישות תסכול ושאלות "למה זה קרה דווקא לי?". זה חלק מההתמודדות עם האבדן, ובדרך כלל הכעס שוכך ככל שעובר הזמן ומתמודדים עם מה שקרה.	אני כועסת – למה דווקא לי זה קרה – ואני אפילו מקנאה בנשים בהריון. זה נורמלי לכעוס ככה?	כעס וקנאה	EMO-015
דצמבר 2025	דגל כתום	קהות רגשית, ניתוק, הגנה	תחושת קהות או חוסר רגש אחרי אירוע כזה היא לא נדירה. לפעמים הגוף והנפש נכנסים למין מצב "הגנה" טבעי, ולא מרגישים כמעט כלום בהתחלה – זו דרך של הגוף להגן עלייך מהכאב מיד. בדרך כלל, אחרי שעובר קצת זמן, הרגשות חוזרים בהדרגה. זה בסדר, כל אחת מגיבה אחרת. במידה ותחושה זו לא חולפת לאחר מספר שבועות מומלץ לשוחח על כך עם איש מקצוע מתחום בריאות הנפש	אני פשוט לא מרגישה כלום מאז ההפלה. זה בסדר?	קהות רגשית	EMO-016
דצמבר 2025	דגל ירוק	הקלה, רגשות מעורבים, לגיטימי	בהחלט. לא כל אחת מרגישה עצב עמוק, ויש נשים שהתחושה העיקרית שלהן אחרי הפסקת הריון היא דווקא הקלה. זה לא אומר שמשוהו לא בסדר אצלך – זה פשוט אומר שזו הייתה כנראה ההחלטה הנכונה עבורך, וההקלה מובנת. כל אישה מגיבה אחרת, וכל רגש הוא לגיטימי.	האמת שאני בעיקר מרגישה הקלה שזה מאחוריי, וכמעט לא עצובה. זה נורמלי?	הקלה	EMO-017
דצמבר 2025	דגל אדום	קשיי שינה, נדודי שינה	קושי לישון אחרי חוויה מטלטלת הוא תופעה ידועה. הרבה נשים מדווחות שבימים שאחרי הפסקת הריון הן מתקשות להירדם או שישנות מעט מאוד. לרוב, ככל שהזמן עובר והנפש נרגעת, גם השינה חוזרת לעצמה בהדרגה. במידה ותחושה זו לא חולפת לאחר מספר שבועות מומלץ לשוחח על כך עם איש מקצוע מתחום בריאות הנפש	אין לי כמעט שינה מאז ההפלה. זה יעבור לי מתישהו?	קשיי שינה	EMO-018

דצמבר 2025		מצבי רוח, תנודתיות, החלמה	כן, זה לגמרי רגיל. אחרי הפסקת הריון, הרגשות יכולות להתנדנד – יום אחד את מרגישה יציבה ויום אחר עולה שוב גל של עצב או כעס. תהליך ההחלמה הרגשית הוא לא ישר כמו סרגל, וברוב המקרים התחושות מגיעות והולכות בגלים לפני שהן נרגעות.	יום אחד אני מרגישה בסדר, ולמחרת שוב עצובה וכועסת. זה נורמלי שהרגשות באים והולכים ככה?	שינויים במצב הרוח	EMO-019
דצמבר 2025		החלמה, זמן, תקווה	זה טבעי לחשוב ככה בהתחלה, אבל התחושות הקשות לרוב לא נמשכות לנצח. קשה להגיד בדיוק מתי תרגישי טוב יותר, כי כל אחת מחלימה בקצב אחר. בדרך כלל עם חלוף השבועות והחודשים, הרבה נשים מבחינות בהקלה ובהדרגה חוזרות להרגיש יותר כמו עצמן.	אני מרגישה שאני לעולם לא אחזור לעצמי. מתי כבר ארגיש יותר טוב?	החלמה רגשית	EMO-020

פרק 3: חוקי דגלים רפואיים

מזהה חוק	סוג סימפטום	רמת הדגל	תיאור תבנית	פעולה נדרשת	הודעה למטופלת	תאריך עדכון
TRI-RED-001	תסמין	אדום	חום מעל 38 מעלות שנמשך מעל יומיים/ חום מעל 39 מעלות	הפנייה למיון נשים	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	28/12/2025
TRI-RED-002	תסמין	אדום	דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה)	הפנייה למיון נשים	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	28/12/2025
TRI-RED-003	תסמין	אדום	חום מעל 38°C שאינו יורד תחת טיפול באקמול/אופטלגין/נורו פן/אדוויל או כל משכך כאבים אחר	הפנייה למיון נשים	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	28/12/2025
TRI-RED-004	תסמין	אדום	כאב חריג/בלתי נסבל שאינו משתפר במשככי כאבים רגילים	הפנייה למיון נשים	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	28/12/2025
TRI-RED-005	תסמין	כתום	אין דימום בכלל יותר משבוע אחרי הטיפול	פניה לרופא זמין בימים הקרובים. עד 3 ימים.	ייתכן והמצב שאת מתארת מעיד על כישלון הטיפול, מומלצת בדיקה של רופא נשים בהקדם.	28/12/2025

28/12/2025	ייתכן והמצב שאת מתארת מעיד על כישלון הטיפול, מומלצת בדיקה של רופא נשים בהקדם.	פניה לרופא זמין בימים הקרובים. עד 3 ימים.	המשך סימני הריון לאחר טיפול תרופתי	כתום	תסמין	TRI-RED-006
28/12/2025	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	הפנייה למיון נשים	הפרשה נרתיקית חריגה מאוד – ריח חריג, כמות גדולה/צבע יוצא דופן	אדום	תסמין	TRI-RED-007
28/12/2025	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	הפנייה למיון נשים	סימני זיהום (חום, צמרמורות, דימום מוגבר, הפרשה חריגה	אדום	תסמין	TRI-RED-008
28/12/2025	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	הפנייה למיון נשים	חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת ונפילה	אדום	תסמין	TRI-RED-009
28/12/2025	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	הפנייה למיון נשים	קוצר נשימה, קושי בדיבור	אדום	תסמין	TRI-RED-010
28/12/2025	זוהי שאלה שיש להפנות לרופא הנשים שלך או לרופא שתפגשי בביקור הראשון טרם התחלת הטיפול התרופתי		שאלות על מצבים רפואיים חריגים כולל רקע רפואי כלשהו, מחלות כרוניות, הפרעות קרישה שונות כמו חסר או מוטציות בפקטורי קרישה, APLA, טיפול אנטיקואגולנטי, אירועים טרומבואמבוליים בעבר אישי או משפחתי (תסחיף ריאה, אירוע מוחי, התקף לב), תחת טיפול תרופתי קבוע		רקע רפואי	TRI-RED-011
28/12/2025	זוהי שאלה שיש להפנות לרופא הנשים שלך או לרופא שתפגשי בביקור הראשון טרם התחלת הטיפול התרופתי	פניה לרופא זמין בימים הקרובים. עד 3 ימים.	חריגה בבדיקת מעבדה	כתום	רקע רפואי	TRI-RED-012
28/12/2025	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	הפנייה למיון נשים	הריון חוץ רחמי, הריון בצלקת ניתוחית, הריון בצלקת קיסרי	אדום	הריון לא תקין	TRI-RED-013

28/12/2025	ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עליך. בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש, כדי לקבל תמיכה ולהקל על ההתמודדות. פנייה לפסיכולוגית, עובדת סוציאלית או גורם טיפולי אחר היא צעד מקובל ונכון במצבים כאלה, ואינה מעידה על חולשה או בעיה אצלך. אפשר להתחיל דרך קופת החולים או דרך גורם מקצועי פרטי, אפילו בשיחה אחת בלבד.	הפניה לתמיכה בתחום בריאות הנפש	התחושות הקשות לא נרגעות עם הזמן ונמשכות כמה שבועות בלי שיפור.	כתום	בריאות הנפש	TRI-RED-014
		הפניה לתמיכה בתחום בריאות הנפש	העצב, החרדה או המתח מפריעים לך לתפקוד היומיומי – עבודה, לימודים, טיפול בילדים או שגרה בסיסית.	כתום	בריאות הנפש	TRI-RED-015
		הפניה לתמיכה בתחום בריאות הנפש	הצפה ריגשית תמידית, ללא תחושת הקלה	כתום	בריאות הנפש	TRI-RED-016
		הפניה לתמיכה בתחום בריאות הנפש	קושי לישון, לאכול, או להתרכז לאורך תקופה	כתום	בריאות הנפש	TRI-RED-017
		הפניה לתמיכה בתחום בריאות הנפש	תחושת בדידות, חוסר שיתוף של התחושות	כתום	בריאות הנפש	TRI-RED-018

פרק 4: מידע שימושי

עיר	מוסד רפואי	סוג מוקד	כתובת	טלפון	מייל	שעות פעילות
חולון	מיון נשים - המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון	מיון	הלוחמים 62, חולון	03-5028490		24/7

ימים א-ה שעות 14:30 – 08:00	Elinam@wmc.gov.il	03-5028490 או whatsapp 035028111	הלוחמים 62, חולון	מרפאה	מרפאת נשים – המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון	חולון
ימים א-ה שעות 15:30 – 08:00	vaadas@wmc.gov.il	03-5028455	הלוחמים 62, חולון	שירות סוציאלי	שירות סוציאלי – המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון	חולון
24/7	https://www.gov.il/he/service/wolfson-book-medical-appointment	03-5028111 בשיחת טלפון או וואטסאפ	הלוחמים 62, חולון	זימון תורים	המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון	חולון

פרק 5 - הצהרות ודיסקליימרים

מזהה	טקסט הצהרה	מתי להציג	רמת חשיבות	הערות
DSC-GEN-01	המידע הכלול בצ'אט הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי אישי.	תמיד	1	
DSC-GEN-02	המידע בצ'אט הינו כללי. במידה ויש לך מחלות כרוניות או שאת נוטלת טיפול תרופתי קבוע המידע בצ'אט אינו מספק ויש להתייעץ עם רופא הנשים שלך.	בהעלאת מצבים רפואיים כרוניים או תרופות קבועות	1	
DSC-GEN-01	המידע הכלול בצ'אט הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי אישי.	תמיד	1	
DSC-RED-01	המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה, לכן יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין.	דגל אדום	1	

	1	דגל אדום	ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עליך. בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש, כדי לקבל תמיכה ולהקל על ההתמודדות. פנייה לפסיכולוגית, עובדת סוציאלית או גורם טיפולי אחר היא צעד מקובל ונכון במצבים כאלה, ואינה מעידה על חולשה או בעיה אצלך. אפשר להתחיל דרך קופת החולים או דרך גורם מקצועי פרטי, אפילו בשיחה אחת בלבד.	DSC-RED-02
--	---	----------	--	------------

Semi-structured Data

מאגר ידע פתוח

קווים מנחים רפואיים כלליים

חלק זה יכול תקצירים של נהלים רפואיים רלוונטיים, הנחיות כלליות לטיפול, למעקב, או לתופעות שאחרי ההליך, הסברים על תופעות לוואי צפויות לעומת חריגות.

מתוך הפרוטוקול המחלקתי

הפסקות הריון יזומות / ביצוע הפלות עד שבוע 13 מלא (7/712) באישור ועדה במוסדנו מאשרים הפסקת הריון באישור ועדה.

אפשרויות הטיפול מוצעות על פי גיל ההריון בעת ביצוע ההפלה:

בטרימסטר ראשון, עד שבוע 13+0 מוצעות 2 אפשרויות טיפול:

- השיטה התרופתית – מוצעת רק עד שבוע 9.

הטיפול ניתן במסגרת מיון/מרפאת נשים ולאחר קבלת הטיפול האישה משתחררת לביתה.

(עד שבוע 9 על פי הנחיות משרד הבריאות, סביב 80%-98% הצלחה, כאשר ככל שגיל ההריון מתקדם יותר ישנה ירידה באחוזי ההצלחה)

▪ השיטה הניתוחית – מוצעת עד שבוע 13+0

(סביב 95% הצלחה)

למטופלת מוצעות 2 האפשרויות (בהתאם לשבוע בו נמצאת), מוסברים סיכויי ההצלחה, סיכונים וסיכונים של כל אחת מהאפשרויות הטיפוליות והיא בוחרת באופן הטיפול המועדף עליה.

השיטה התרופתית (תתאפשר רק עד שבוע 9):

ניתן לבצע הפסקת הריון עד שבוע 9 (63 יום) באמצעות תרופות

(מפיג'ין + ציטוטק במינון ולפי הכללים שנקבעו ע"י משרד הבריאות).

התוויות נגד: אנמיה קשה, התקן תוך רחמי, הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה, מחלת כבד פעילה, מחלה קרדיווסקולרית, אפילפסיה לא מאוזנת ואסטמה.

– Mifepristone (Mifegyne) 600 mg

מקבלת האישה 3 טבליות של 200 מ"ג, דרך הפה, נשארת להשגחה של 20 דקות ומשתחררת לביתה.

▪ יש לצייד את המטופלת ב-400 מק"ג ציטוטק (2 טבליות) לצורך טיפול פומי, ולהדריך אותה כיצד ומתי ליטול את התרופה (כעבור 48 שעות מנטילת המפיג'ין, בבליעה).

▪ יש להסביר על המהלך הצפוי (דימום/כאבים) ועל תופעות לוואי אפשריות, וכן להמליץ על שימוש במשככי כאבים.

▪ לחלופין, ניתן להציע למטופלת להגיע למרפאה לצורך קבלת ציטוטק, במקום ליטול אותו בעצמה בביתה.

▪ הוראה לקבלת אנטי-D על פי צורך בקופת חולים, בתוך 72 שעות.

האישה תוזמן לביקורת כעבור שבועיים ואם עובי הרירית בבדיקת ה-US הוא 15 מ"מ או פחות – מסתיים הטיפול.

באם עובי הרירית יותר מ-15 מ"מ תוזמן לביקורת נוספת ומעקב או לגרידה לפי החלטת הרופא.

פראמין או נוגדי כאבים יינתנו לפי הצורך.

במקביל לטיפול התרופתי יש לדאוג ל:

▪ ביצוע ספירת דם וסוג דם בקופת חולים.

▪ החתמת החולה על טופס הסכמה בעת קבלתה לפני כל פעולה.

▪ בירור צורך במתן אנטי-D במינון 300 מק"ג.

בסיום הטיפול, טרם השחרור, האישה מקבלת ייעוץ לאמצעי מניעה במסגרת המיון ומשתחררת עם מרשם לגלולות אותן תוכל להתחיל לקחת עוד באותו היום.

הפסקת הריון ניתוחית (dilation and curettage, D&C)

טרם הפעולה יש לדאוג כי האישה תשלים:

▪ ספירת דם וסוג דם בקופת חולים.

▪ מעל גיל 40 – ביצוע אק"ג.

▪ עיון בטופס הוועדה להפסקת הריון וציון מספר הטופס בגיליון הקבלה.

▪ החתמת החולה על טופס הסכמה בעת קבלתה לפני כל פעולה (כולל הכנסת למינריה).

- שקילת החדרת למינריה או לחילופין 400 מק"ג מיזופרוסטול דרך הנרתיק או פומי 2-4 שעות לפני הפעולה.
- ביצוע C&D עם כיסוי אנטיביוטי טרם הפעולה.
- ביצוע US בסיום הפעולה לוודא שהרחם ריק והשארת תמונה בגיליון במידת האפשר.
- שליחת רקמה להיסטולוגיה.
- בירור סוג דם ובמידת הצורך מתן Anti-D טרם השחרור.

הנחיות לתקופת התהליך:

1. להימנע משימוש בטמפונים במשך כל זמן הדימום
2. להימנע משימוש בריכות מים עומדים (אמבטיה, בריכה, ים, ג'אקוזי)
3. להימנע מקיום יחסי מין בזמן הדימום
4. במקרה של עליית חום, כאבים חזקים או דימום מוגבר עלייך להיבדק ע"י רופא נשים
5. ביקורת נוספת אצל גניקולוג מטפל לאחר הופעת ווסת

חומרי הסברה למחלקה

חלק זה יכיל ידע כללי על המחלקה והשירותים שהיא מעניקה, הסבר על דרכי פנייה - טלפון, מייל, זמני פעילות, מידע על תהליכי המשך טיפול, ביקורות וקביעת תורים.

ועדה להפסקת הריון בית חולים וולפסון

מי יכולה לפנות לוועדה

העומדות בכל התנאים הבאים:

- מעל גיל 18 ולא נשואה, או מעל גיל 40 ונשואה
- גיל ההיריון קטן מ 14 שבועות
- חברת קופת חולים מכבי, או בעלת טופס 17 לוועדה (קוד L0209) או אישור תקציבי מהצבא
- מה צריך לצרף לפנייה
- תעודת זהות, כולל ספח
- מסמכים מבדיקת רופא או רופאת נשים המעידים על הריון
- תמונת אולטרה סאונד עדכנית שעליה מופיעה שם המטופלת
- מסמכים רפואיים אחרים - אם סיבת הפנייה היא מום גופני של העובר, או חשש לנזק גופני או נפשי לחיי האישה

איך מגישים את הפנייה

יש למלא **בקשה להפסקת הריון**, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח באופן מקוון.

- ההגשה מתבצעת לאחר הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית ומספקת שירות מותאם אישית לאחר רישום קצר וחד-פעמי, תוך אבטחה מקסימלית המגנה מהונאה ומגניבת זהות
- **לסרטוני הסבר על אופן ההרשמה**
- **שאלות נפוצות - הרשמה למערכת ההזדהות הלאומית**

לחילופין, ניתן לתאם תור לוועדה אצל מזכירת השירות הסוציאלי בטלפון 03-5028455, שלוחה 2

בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 15:30

ניתן לפנות גם בדואר האלקטרוני: vaadas@wmc.gov.il

המשך הטיפול בפנייה

- הוועדה מתכנסת שלוש פעמים בשבוע: בימים א', ג' ו-ה', בבניין מרפאות חוץ, קומה ראשונה, מרפאת סוכרת חדר 104
- מזכירת הוועדה תהיה בקשר עם הפונות, לייעוץ עם רופא או רופאת הוועדה באמצעות הדואר האלקטרוני.
- חברי הוועדה:

○ רופא או רופאה בעלי תואר מומחיות בגינקולוגיה

○ רופא או רופאה בכירים

○ נציגי הנהלת המרכז הרפואי

○ עובדת סוציאלית בכירה

- אישור הוועדה יישלח לדואר האלקטרוני, עם קבלתו ניתן **לקבוע תור לביצוע ההליך הרפואי בבתי החולים.**

השירות ניתן ללא עלות

קביעת התור לביצוע ההליך הרפואי יכולה להתבצע דרך אתר זימון תורים של וולפסון, במוקד זימון תורים או בוואטסאפ של זימון תורים במספר 03-5028111

לשאלות דחופות:

1. מרפאת נשים 03-5028489 ימים א-ה בין השעות 07:00-15:00, מייל Elinam@wmc.gov.il
2. מיון נשים 03-5028717/8 24/7

עלויות

הפלה נדחית

- תרופתי – לא נדרש טופס 17
- ניתוחי – תלוי קופה
- מכבי – לא נדרש טופס 17
- כללית/ לאומית/ מאוחדת – נדרש טופס 17
- הפסקת הריון יזומה – ללא תלות באופן הטיפול
- ועדה – כולן צריכות להביא טופס 17.
- חברות קופ"ח מכבי
- אם רווקה/גרושה/אלמנה לא נדרש טופס 17
- אם נשואה נדרש טופס 17
- קופ"ח אחרות – כללית/ לאומית/ מאוחדת – נדרש טופס 17
- תעריפי משרד הבריאות להפסקת הריון, נכון לינואר 2025 –
- הפסקת הריון תרופתית (כולל הפסקה כירורגית לאחר מכן, אם נדרשת): 2,642 ₪ (בהפניה מקופת החולים) או 2,715 ₪ ללא הפניה.
- הפסקת הריון כירורגית: 3,667 ₪ (בהפניה מקופת החולים) או 3,768 ₪ ללא הפניה

תיאור כללי של התהליך

הגדרה של הפלה - סיום ההיריון, מכל סיבה שהיא, לפני גיל החיות של העובר .
 ההגדרות המקובלות מתייחסות להריון מתחת לשבוע 20 או מתחת למשקל 500 גר'.
 אפידמיולוגיה: השכיחות המדווחת היא של כ- 15% מכלל ההריונות המאובחנים קלינית. אם כוללים גם הריונות כימיית, השכיחות כנראה גבוהה פי 2-3.
 השיעור עולה עם גיל האם, מכ- 12% בגיל 20 לכ- 80% אצל נשים בגיל 45 ומעלה .
 קיימות שתי חלוקות של הפלות לפי גיל הריון:

- הפלה מוקדמת - עד שבוע 13
- הפלה מאוחרת - שבוע 14-20

סוגי הפלות

הפלה מאיימת

כל הפרשה דמית מהלדן או דמם מהרחם המתרחשים במחצית הראשונה של ההיריון נחשבו באופן מסורתי כהפלה מאיימת. מופיע בכ- 20-25% מהנשים. הסיכון נמוך יותר באופן משמעותי עד אחוזים בודדים כאשר מודגם דופק עוברי באולטר-ה-סאונד. כאשר ההיריון נמשך, ישנו סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, משקל לידה נמוך. גם אם הדמם מועט, הוא יכול להיות מלווה בכאבי בטן cramping או כאבי גב תחתון .
 בבדיקה צוואר הרחם ארוך וסגור ואין מעבר רקמה אין טיפול שיעילותו מוכחת. הטיפול כולל הסבר מפורט למטופלת על הבעיה והפרוגנוזה. ניתן לאפשר מנוחה והימנעות ומיחסי מין . בד"כ אין צורך בטיפול בפרוגסטרון

אובדן הריון מוקדם Early pregnancy loss

אובדן הריון מוקדם (early pregnancy loss) או הפלה נדחית (missed abortion) מוגדר כהריון לא ויאבילי בשליש הראשון .

קריטריונים לאבחנה :

- הדגמת קוטב עוברי עם מדידת CRL של 7 מ"מ או יותר ללא דופק
- הדגמת שק הריון בקוטר ממוצע של 25 מ"מ או יותר ללא קוטב עוברי
- העדר דופק עוברי שבועיים או יותר לאחר הדגמת שק הריון שלא הודגם בו שק חלמון
- העדר דופק עוברי 11 ימים או יותר לאחר הדגמת שק הריון עם שק חלמון
- היעדר דופק עוברי בהריון שגילו 7.0 שבועות לפחות :
- 3 שבועות או יותר לאחר בדיקת הריון חיובית (כמותית/ איכותית)

- הריון IVF לפי חישוב גיל הריון

טיפול באובדן הריון מוקדם: על פי חוזר משרד הבריאות:

ריקון חלל הרחם יבוצע מהר ככל הניתן ועד 72 שעות מרגע גילוי אובדן ההריון.

יש להמליץ למטופלת על טיפול אקטיבי, כירורגי או תרופתי (מפיג'ין+ציטוטק). טיפול תרופתי בהפלה

נדחית ניתן להציע עד שבוע 12.

הפלה בלתי נמנעת והפלה בלתי שלמה

הפלה בלתי נמנעת והפלה בלתי שלמה הן בעלות אותו מופע קליני ומטופלות באותו אופן.

הפלה בלתי נמנעת מאובחנת כאשר יש דמם רב או פקיעת קרומים ופתיחה של צוואר הרחם בנוכחות דופק

עוברי. הפלה בלתי שלמה מאובחנת כאשר מופיע כל האמור לעיל ויש מעבר חלקי של רקמה דרך הצוואר.

הדמם יכול להיות ניכר ואף לגרום להיפּוּוּלמיה. אבחנה נעשית בבדיקה לדנית וסונר. כאשר ההפלה

מתרחשת בשליש הראשון של ההריון או בשליש השני, נותרים בד"כ חלקי שליה בחלל הרחם המחייבים

השלמת ריקון חלל הרחם.

הפלה שלמה

הפלה בה כל רקמת ההריון נפלטת. במקרה זה, הדמם בד"כ קל והפה הפנימי של צוואר הרחם סגור.

אין צורך בריקון הרחם. האבחנה נעשית על ידי אולטראסאונד ולאחר שנשללה אפשרות של הריון חוץ רחמי

טיפול תרופתי בהפלה נדחית

הטיפול התרופתי בהפלה נדחית הינו תהליך המבוצע עד שבוע 12 להריון, לפי גודל העובר, ומבוסס על

נטילת תרופה דרך הפה, הגורמת לעצירת התמיכה ההורמונלית של ההריון, ולאחר מכן נטילת כדורים דרך

הנרתיק, אשר גרומים לגרימת התכווצויות רחם ויציאה של תוכן ההריון, ובכך סיום ההריון.

שלבי התהליך:

3. ביקור ראשון:

o מפגש עם רופא, סקירת רקע רפואי, וידוא האבחנה של הפלה נדחית, ואישור שאין התוויות

נגד (הריון מתקדם, אנמיה חמורה, נטייה לדימומים וכו').

o קבלת כדור מפיג'ין, מינון של 200 מ"ג (Mifepristone).

- o המפיג'ין הוא חומר הנוגד את פעולות של הורמון הפרוגסטרון, התומך בהריון. נטילה של הכדור מפסיקה את התמיכה של ההריון ומשפרת את סיכויי ההצלחה של ההליך.
- o את כדור המפיג'ין יש ליטול במעמד קבלת הטיפול בחדרו של הרופא.
- o לאחר נטילת הכדור מומלץ להמתין כ-20 דקות להשגחה במרפאה לזיהוי מוקדם של תגובה אלרגית
- o תופעות אפשריות: ברוב המקרים תחושי בחילה המתלוות לבחילות של הריון צעיר. בנוסף ייתכנו התכווצויות או התחלת דימום -- ייתכן שגם לא יופיעו תסמינים מיד.
- o מה צריך להביא למפגש?

1. מכתב הפניה מהרופא אשר מאשר את האבחנה של הפלה נדחית

2. בדיקות דם כולל ספירת דם וסוג דם מהחודש האחרון

4. בבית, כעבור 48 שעות מנטילת מפיג'ין

- o ביום הביקור הראשון תקבלי ארבעה כדורי ציטוטק (Misoprostol), מינון של 800 מק"ג, אותם יש להניח בנרתיק, עמוק ככל שניתן, שמעוררים התכווצויות רחם וריקון תוכן ההריון.
- o בימים שלאחר נטילת הציטוטק -- צפויים כאבים עזים ודימום משמעותי (כמו מחזור חזק). למי שילדה בעבר הכאבים והדימום מזכירים את היום הראשון לאחר הלידה.
- o נצפה לראות קרישי דם, וגושים הדומים ל"כבד" וכן נצפה לכאבים חזקים והתכווצויות בבטן תחתונה, רוב הנשים מתארות כאבים אלו ככאבים משמעותיים יותר מכאבי מחזור.
- o בנוסף תיתכן חולשה, בחילות, כאבי ראש ואף עליית חום קלה. מומלץ לנוח בבית, להצטייד במשככי כאבים ופדים עבים.

1. מדובר על 3-4 ימים בהם לא תרגישי טוב.

2. כל משכך כאבים שעוזר לך בזמן המחזור יעזור גם פה -

נורופן/אדוויל/אקמול/אופטלגין. הקפידי ליטול לפי ההמלצות הרוקחיות.

- o לאחר כמה ימים לרוב תחול הטבה משמעותית בהרגשה; דימום מתון וכאבים קלים יכולים להמשך עד שבועיים.

5. ביקורת:

- o בעת סיום הביקור הראשון נתאם לך תור לביקורת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק
- o במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד בגישה נרתיקית לוודא שהרחם התרוקן ואין שאריות הריון.

- o אם ההליך הסתיים - ניתן לחזור לפעילות רגילה, מומלץ להתחיל להשתמש באמצעי מניעה.
- o אם יש שארית ברחם -- יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק, או גרידה ניתוחית). במידה ותקבלי טיפול תרופתי נוסף- תוזמני לביקורת נוספת כעבור שבוע.

מדוע הטיפול מורכב ממפיג'ין וציטוטק?

- o נותנים גם מפיג'ין (Mifepristone) ולא רק ציטוטק (Misoprostol) כי שילוב התרופות משפר משמעותית את יעילות ההפסקה התרופתית לעומת שימוש בציטוטק בלבד, ומפחית את שיעורי הכישלון והצורך בהתערבות ניתוחית. טיפול משולב הוא הסטנדרט במרבית מדינות ומרכזים רפואיים, ורק במקביל קיימת אפשרות לשימוש בלעדי בציטוטק כאשר נחוץ.
- o מנגנון פעילות מפיג'ין: זהו אנטי-פרוגסטרון החוסם את השפעת הפרוגסטרון ברחם, שהוא הורמון חיוני להמשך ההריון. בכך הוא מחליש את רירית הרחם ומעורר הגברה בתגובת הרחם לפרוסטגלנדינים, כלומר מגביר את ההשפעה המרוקנת של ציטוטק.
- o ציטוטק: יוצר התכווצויות רחם ופינוי פיזי של תוכן ההריון.
- o יתרונות השילוב:
- o שיעורי הצלחה של מעל 95-98% להשלמת הפסקת ההריון בשבועות המוקדמים.
- o פחות מקרים של המשך הריון/שארית ברחם לעומת טיפול בציטוטק בלבד.
- o פחות צורך בכירורגיה משלימה (גרידה).
- o אם מפיג'ין אינו נגיש/אסור - אפשרי להשתמש בציטוטק בלבד, אך יעילות ההליך יורדת (שיעור כישלון עולה לכ-10-15%).
- o פחות מ-1% מההפסקות הריון מצריכות פנייה דחופה למיון
- o הטיפול תרופתי בטוח מאוד עד שבוע תשע להריון, ומבוצע תחת השגחה וניטור רפואי. רוב המטופלות עוברות את ההליך בהצלחה.

תופעות לוואי של הטיפול:

- מפיג'ין: תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים.
- ציטוטק: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C, צמרמורות.

- שכיחות: בחילה (43%-66%), שלשול (23%-35%), כאב ראש (13%-40%), חום/צמרמורות (32-69%)

הנחיות לתקופת התהליך:

1. להימנע משימוש בטמפונים במשך כל זמן הדימום
2. להימנע משימוש בריכות מים עומדים (אמבטיה, בריכה, ים, ג'אקוזי)
3. להימנע מקיום יחסי מין בזמן הדימום
4. במקרה של עליית חום, כאבים חזקים או דימום מוגבר עלייך להיבדק ע"י רופא נשים
5. ביקורת נוספת אצל גניקולוג מטפל לאחר הופעת ווסת

התוויות נגד לטיפול תרופתי להפלה נדחית בגינן ניתן לבצע

הפסקת הריון ניתוחית בלבד -

- הריון מעל שבוע 12+0 על פי אולטרסאונד
- אנמיה קשה (המוגלובין > 9)
- הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה
- מחלת כבד פעילה
- מחלה קרדיווסקולרית
- אפילפסיה לא מאוזנת
- אסטמה
- חשד להריון חוץ-רחמי. או הריו בצלקת של ניתוח קיסרי
- אלרגיה לתרופות הפלה.
- אי-יכולת לעמוד במעקב או הוראות טיפול.
- חוסר הבנה/שיתוף פעולה, בעיות פסיכיאטריות קשות

יתרונות השיטה:

- נמנעת פעולה פולשנית בהרדמה כללית.
- תהליך שיכול להתבצע בבית, בסביבה הנוחה והפרטית שלך
- ללא השפעה על פיריון עתידי

חסרונות השיטה:

- ב-5%-10% מהמקרים יש צורך להשלים פעולה ניתוחית.
- הטיפול דורש כמה ביקורים; יכול להימשך מספר שבועות.
- צפוי כאב ודימום משמעותי במשך מספר ימים.

דגלי אזהרה – מתי לפנות לרופא מוקדם מהרגיל?

- דימום כבד ביותר ("ברז" יותר משתי תחבושות גדולות בשעה לשעתיים רצופות)
- חום מעל 38 מעלות צלזיוס שאינו מגיב לטיפול במשככי כאבים
- כאב חריג שאינו מוקל במשככי כאבים
- חולשה חריגה, סחרחורת או סימני עילפון
- הפרשה נרתיקית חריגה או ריח חריג

גבולות הגזרה של הסוכן – מתי מפנים לרופא מוסמך ולא עונים עצמאית

2. דגלי אזהרה רפואיים (סימפטומים חריגים המחייבים התערבות מיידית):

- דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה)
- חום מעל 38°C שאינו יורד תחת טיפול באקמול/אופטלגין/נורופן/אדוויל או כל משכך כאבים אחר
- כאב חריג/בלתי נסבל שאינו משתפר במשככי כאבים רגילים
- חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת ונפילה
- הפרשה נרתיקית חריגה מאוד – ריח חריג, כמות גדולה/צבע יוצא דופן
- סימני זיהום (חום, צמרמורות, דימום מוגבר, הפרשה חריגה)
- המשך סימני הריון לאחר טיפול תרופתי
- אין דימום בכלל יותר משבוע אחרי הטיפול

3. שאלות אבחוניות/פרטניות הדורשות בדיקה של רופא:

- אבחון מדויק של סוג ההריון (לדוג' חשש להריון חוץ-רחמי/הריון בצלקת)
- פענוח ספציפי של בדיקת אולטרסאונד/מעבדה

- שאלות על מצבים רפואיים חריגים (רקע רפואי מסובך, מחלות כרוניות, הפרעות קרישה שונות כמו חסר או מוטציות בפקטורי קרישה, APLA, טיפול אנטיקואגולנטי, אירועים טרומבואמבוליים בעבר, אינדיקציה לתרופות ייחודיות, תחת טיפול תרופתי קבוע)
- 4. המלצה או התחלת טיפול תרופתי חדש, שינוי מינון או הפסקה של תרופה
 - אם נדרשת המלצה לשינוי בטיפול או במינון רפואי — אין מענה עצמי אלא הפניה לרופא.
- 5. שאלות משפטיות, זכויות חריגות, בירורים כספיים אישיים
 - בירור על פתיחת תיקים אישיים/בקשת החזר/תביעה רפואית וכדומה
 - התייעצות בנוגע למעורבות בן הזוג/ המשפחה/ מקום העבודה
- 6. מצבים שיש בהם סכנת חיים / צורך דחוף בשירותי רפואה חירום
 - כל הודעה על סכנת חיים, חשד להריון מחוץ לרחם, קוצר נשימה המחשיד לתסחיף ריאתי, כשל נשימתי.
- 7. פניות חוזרות על חוסר התקדמות רפואית/תסמינים ממושכים
 - דימום שנמשך מעבר ל-3 שבועות
 - חום/כאבים ממושכים גם אחרי טיפול וניטור
 - כל דבר העולה מעל למידע הכללי ומצריך בירור פרטני.

הריון אצל נערות וקטינות

קבלת החלטה

- אם את בהריון, יש לך למעשה שלוש אפשרויות:
- להמשיך בהריון ולגדל את התינוק.
 - להמשיך בהריון ולמסור את התינוק לאימוץ.
 - לעבור הפסקת הריון בבית החולים.
- כיצד את מרגישה לגבי ההריון?
- הריון לא מתוכנן יכול לעורר רגשות מעורבים. למעשה, מרבית הנערות מרגישות כך.
- אפשר להרגיש, למשל:
- דאגה לגבי יכולתך לטפל ולהפוך לאחראית על תינוק.

חשש מויתור על דברים אחרים החשובים לך.

פחד מתגובתם של אנשים אחרים.

באותו הזמן אפשר להרגיש:

שמחה לדעת שאת מסוגלת להיכנס להריון.

שמחה על האפשרות לגדל תינוק.

נרגשת לגבי האירוע הייחודי והחדש בחיך.

לפני שאת מקבלת החלטה, את יכולה לשאול את עצמך את השאלות הבאות:

מהם הדברים החשובים לי ביותר בחיי עכשיו?

מהם החלומות והתכניות שלי לעתיד?

מה אפסיד או ארוויח בשלב זה של חיי אם יהיה לי תינוק?

האם אני מאמינה שבשלב זה של חיי אוכל לגדל תינוק כמו שצריך?

כיצד אנשים משמעותיים עבורי יגיבו להריון (כמו בן הזוג, ההורים או החברים)?

מבולבלת?...

אם את מתלבטת מה לעשות לגבי ההריון, דברי עם אדם שאת סומכת עליו במיוחד.

אדם, שלא יחליט בשבילך אלא יעזור לך לקבל את ההחלטה הטובה עבורך.

אדם זה יכול להיות:

הורה או קרוב משפחה אחר.

בן זוג שדואג לך.

חברה קרובה.

יועצת או מורה בבית הספר.

רופא/ת נשים או רופא/ת משפחה.

איש מקצוע במרכז ייעוץ לנוער הקרוב לאזור מגוריך.

צוות הועדה להפסקת הריון בבית החולים.

זכרי:

זה הגוף שלך! אף אחד לא יכול להחליט בשבילך ולהכריח אותך ללדת או לעשות הפלה.

אף אחד לא יכול להיות בטוח במאת האחוזים לגבי ההחלטה "המושלמת".

הפסקת הריון

הפסקת הריון יזומה הנה הליך רפואי מכוון אשר גורם לסיום ההריון.

בישראל ישנה רק דרך חוקית אחת לעבור הפסקת הריון יזומה.

הפסקת הריון מתבצעת לאחר קבלת אישור מוועדה המורשית לכך, היושבת בדרך כלל בבית חולים ובמקרים בודדים במרפאה כירורגית בקהילה.

הוועדה מונה שלושה חברים - שני רופאים ועובדת סוציאלית.

הוועדה דנה בבקשה, ואם היא מאשרת אותה יקבע לך תור נוסף לביצוע הפסקת הריון.

הוועדה מאשרת בקשות כאשר מתקיים אחד מהתנאים:

כאשר את למטה מגיל 17.

כאשר את אינך נשואה.

כאשר ההריון נובע מיחסים אסורים (אונס או גילוי עריות).

כאשר התינוק עלול להיוולד בעל מום.

כאשר המשך ההריון עלול לסכן את חייה או לגרום לך נזק נפשי.

מהן הזכויות שלך?

רופאים, אחיות או עובדים סוציאליים מחויבים לשמור על פרטייך בסוד ולא למסור מידע ללא הסכמתך.

הסיבה היחידה למסירת מידע ללא הסכמתך היא להגן עליך מפני פגיעה או התעללות (אם את מתחת לגיל 18). במקרה זה על הצוות ליידע אותך.

האם השותף צריך להסכים?

לא. את היא המחליטה היחידה על גופך.

האם ההורים צריכים להסכים?

על פי החוק, אין צורך בהסכמת הורים או ידיעתם בכל גיל.

מרבית ההורים מציעים בסופו של דבר תמיכה ומסייעים לבתם לעבור את התהליך.

האם את יכולה לשנות את דעתך?

את יכולה לשנות את דעתך בכל שלב, עד לתחילת ההליך הרפואי עצמו.

האם הפסקת הריון היא מסוכנת?

הפסקת הריון בפיקוח רפואי הנה בטוחה, ולרוב אינה מלווה בסיבוכים.

במרבית המקרים, היא לא תפגע ביכולתך להרות בעתיד.

כמו בכל ניתוח, עלולים להיות סיבוכים עליהם תקבלי מידע מהצוות.

זכרי: הפסקת הריון איננה "אמצעי מניעה".

כמה זה עולה?

עד גיל 19 על קופת החולים לממן את הפסקת ההריון והפנייה לוועדה.

ניתן לשלם באופן פרטי אם אינך מעוניינת במימון הקופה.

כיצד פונים לוועדה?

יש להצטייד בתעודות מזהות ובמסמכים רפואיים.

מומלץ לבקר קודם אצל רופא/ת נשים או משפחה.

במקרה של קושי (כמו חוסר בתעודת זהות), ניתן להתייעץ עם מזכירת הוועדה או העובדת הסוציאלית.

הטיפול בפניות המגיעות לוועדה:

תופני לעובדת סוציאלית שתייעץ, תדריך ותלווה אותך בכל ההליך.

חברי הוועדה יסבירו לך על התהליך, השיטות והסיכונים.

החלטת הוועדה תימסר לך מיידית.

לאחר האישור תתבקשי לחתום על הסכמה, ולאחר מכן ייקבע תור לביצוע.

כל המידע והמסמכים הם סודיים.

כדאי לדעת: זכותך לשאול כל שאלה המטרידה אותך.

אם ההריון מעל שבוע 24 - תהליך האישור מורכב יותר ודורש ועדה מיוחדת.

מהן השיטות להפסקת הריון?

השיטה נבחרת לפי גיל ההריון ומצב בריאותך:

עד שבוע 7: בליעת כדורים בשתי מנות במרווח של יומיים. נדרשת השגחה בבית החולים וביקור מעקב לאחר שבועיים.

עד שבוע 12: הרדמה מלאה והרחבת צוואר הרחם. חלק מהמרכזים מבצעים זאת עד שבוע 18.

משבוע 12 ואילך: שימוש בחומרים הגורמים להתכווצות הרחם ולסיום ההריון, ולאחר מכן ניקוי הרחם בהרדמה מלאה. דורש אשפוז של כיומיים.

מה קורה ביום הביצוע?

יש להביא מסמכים רפואיים ואישור ועדה.

הצוות יקיים שיחת היכרות והסבר לפני תחילת התהליך.

כדאי לדעת: בקשי מהצוות להסביר כל דבר לפני ביצועו כדי להפיג מתח.

מלווה: מותר לך להביא אדם מטעמך שיהיה נוכח בבדיקה ובשיחות. המלווה לא יורשה להיכנס לחדר הניתוח בזמן הפעולה עצמה.

מומלץ להגיע עם מלווה.

מה קורה אחרי?

ייתכנו תחושות הקלה, עצבות או תחושות מעורבות.

יופיעו דימום והתכווצויות דומים למחזור.

לפני השחרור תקבלי הדרכה לגבי: אנטיביוטיקה, כאבים, חום, אמצעי מניעה ומעקב.

מעקב רפואי נדרש כשבועיים לאחר ההליך.

חשוב להקפיד על מילוי הוראות הרופא/ה!

זכרי: המעקב חיוני לבריאותך.

בזמן הפסקת ההריון, להפגת מתח כדאי לדמיין חוויות חיוביות: טיול בים, מקום בטוח, או אנשים אהובים.

אמצעי מניעה: זו הזדמנות לשקול שימוש באמצעי מניעה למניעת הריון נוסף ומחלות מין.

זכותך להחליט מתי הזמן הנכון עבורך לקיים יחסי מין ללא לחץ. אל תרגישי נקיפות מצפון להגיד "לא כרגע". מין לא בטוח עלול להוביל להריון לא רצוי ולאיידס. קיימות מספר שיטות, כדאי להתייעץ עם רופא/ת נשים.

קונדום: יעיל נגד הריון ומחלות. ניתן לרכישה ללא מרשם.

גלולה: אמצעי הורמונלי יעיל מאוד הדורש נטילה יומית ומרשם רופא. אינה מונעת מחלות מין.

על הגלולות: אינן גורמות להשמנה, אינן פוגעות בפוריות עתידית, ויכולות לשפר את מצב העור.

יעילותן 99.9%.

זכרי: גלולת "היום שאחרי" אינה במקום אמצעי מניעה קבוע!

חשוב לדעת:

ניתן להיכנס להריון בכל יום בחודש, גם בווסת.

ניתן להיכנס להריון בפעם הראשונה.

ניתן להיכנס להריון ללא חדירה או ללא קשר לתנוחה.

"משגל נסוג" אינו בטוח. מקלחת אחרי מין אינה מונעת הריון.

מדריכים למטופלת

חלק זה יכיל שאלות נפוצות FAQ בפורמט טקסט חופשי - רשימת שאלות ששואלות מטופלות בפועל, ניתן לכלול כמה ניסוחים לאותה שאלה כדי לעזור ל-AI לזהות הקשרים.

- כמה זמן דימום נחשב תקין ?
- אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?
- איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידית?
- אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון?
- מהי הפסקת הריון תרופתית?
- מה קורה בביקור הראשון?
- באיזה מקרים לא ניתן לבצע הפסקת הריון תרופתית?
- מהן התוויות הנגד?
- מה להביא לביקור הראשון?
- כמה זמן נמשך הביקור במרפאה?
- מה קורה בביקור הראשון בהרחבה?
- אילו תופעות צפויות אחרי נטילת מפיג'ין?
- אילו תופעות צפויות אחרי הביקור הראשון?
- מה השלב השני של הטיפול? מהו הטיפול בציטוטק?
- האם יש ליטול את הטיפול עם או בלי אוכל?

- מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?
- האם יש הבדל בין דימום רציף לדימום שבא והולך?
- האם הדימום אמור להיעלם בהדרגה או בפתאומיות?
- האם קרישי דם הם תמיד חלק מהתהליך?
- מהן תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי? מה השכיחות שלהן?
- האם חום נמוך הוא תופעה שכיחה?
- ממתי לקחת ימי מחלה? מתי הכל יתחיל? מתי יתחיל החלק העיקרי של התהליך?
- כמה זמן לא מרגישים טוב? ומה קורה אחר-כך? כמה זמן נמשך השלב הלא נוח?
- האם מותר לקחת משככי כאבים? האם מותר לשלב בין משככי כאבים?
- האם מותר להשתמש בקנאביס להקלה על הכאב?
- כמה זמן יימשך הדימום לאחר הציטוטק?
- האם זה נורמלי שעדיין יש בחילות?
- מתי אפשר לחזור לשגרה יומית?
- מתי אפשר לחזור לעבודה?
- האם מותר לעשות פעילות גופנית?
- מתי אפשר לחזור לקיים יחסי מין?
- מתי אמורה להגיע הווסת הבאה אחרי ההפלה?
- האם יש תופעות שיכולות להימשך גם אחרי ההצלחה של ההפלה?
- מתי לעשות בדיקת הריון ביתית?
- מתי צריך להגיע לביקורת?
- כמה ביקורות יש בסך הכל?
- האם צריך לקבוע תור לביקורת?
- איך קובעים תור לביקורת?
- האם אפשר לבצע את המעקב דרך קופת חולים?
- האם אפשר לבצע את המעקב בבית?
- האם הביקורת יכולה להתבצע בבית החולים הקרוב לביתי?
- איפה ניתן לבצע ביקורת נוספת?
- האם אפשר לקבוע את הביקורת למועד אחר?
- אם קבעתי תור לביקורת ואני מרגישה טוב, האם אפשר לבטל את התור?
- איך אדע אם ההפלה הצליחה?
- האם חייבים לעשות אולטרסאונד אחרי ההפלה?
- האם אצטרך לעבור תהליך כירורגי בנוסף לטיפול התרופתי?
- האם במידה וההפלה לא הצליחה – האם תהליך הכירורגי מתבצע באותו היום?
- איך להתכונן לקראת הפרוצדורה הכירורגית במידת הצורך?
- האם הטיפול התרופתי משפיע על הפוריות בעתיד?
- האם ישנן השלכות לטווח הרחוק?
- האם עלי להודיע לרופא הנשים שלי?

- האם התהליך משפיע על המחזור החודשי שלי?
- האם אלכוהול משפיע על היעילות של התרופות?
- האם עישון משפיע על היעילות של התרופות?
- האם מותר לטוס אחרי הטיפול?
- האם מותר לטבול במקווה אחרי הטיפול?
- מה ההבדל בין הפלה תרופתית להפלה כירורגית?
- מה ההבדל בין מיפג'ין לציטוטק?
- האם ניתן לרכוש את התרופות לבד (במרשם רופא)?
- האם יש חסרונות לתהליך?
- למי הטיפול הזה לא מתאים?
- האם יש חשיבות לגיל בהריון לצורך הטיפול?
- האם אפשר לבצע את ההפלה ללא ידיעת הבעל?
- האם מותר לנסוע אחרי נטילת מיפג'ין?
- האם יש הנחיות מיוחדות לימים שבין נטילת המיפג'ין לביקור השני?
- למה אסור להתרחץ עד הביקורת?
- מה להביא לביקורת (אולטרסאונד)?
- מה להביא לפרוצדורה הכירורגית (גרידה)?
- מה להביא לביקורת בבית חולים?
- האם יש צורך בשירותי מעבדה (בדיקות דם) במהלך הטיפול?
- כמה זמן לאחר ההפלה ניתן לנסות שוב להרות?
- האם יש תמיכה נפשית בבית חולים וולפסון לאחר ההפלה?
- האם יש גורמי סיכון ידועים להפסקת הריון?
- למי עלי לפנות כשיש לי שאלות לאחר השחרור?
- מה להביא לוועדה?
- האם הטיפול להפסקת הריון עולה כסף?
- האם אני צריכה להביא טופס 17 לוועדה ולטיפול?
- מה העלות של הפסקת הריון?
- האם אני זכאית למימון של הפסקת הריון?

אבחנה

- **שאלה:** מהי הפלה נדחית?
- **תשובה:** אובדן הריון מוקדם (early pregnancy loss) או הפלה נדחית (missed abortion) מוגדר כהריון לא ויאבילי בשליש הראשון. הגורם העיקרי הינו פגם גנטי נקודתית בהריון הספציפי, אשר מוביל להפסקתו בשלב מוקדם. בד"כ, הפגם הגנטי הוא ספציפי להריון הנוכחי, ואינו חוזר בהריונות הבאים.
- **שאלה:** כיצד מאבחנים הפלה נדחית
- **תשובה:** קריטריונים לאבחנה על פי אולטרסאונד:
 - הדגמת קוטב עוברי עם מדידת CRL של 7 מ"מ או יותר ללא דופק.
 - הדגמת שק הריון בקוטר ממוצע של 25 מ"מ או יותר ללא קוטב עוברי.
 - העדר דופק עוברי שבועיים או יותר לאחר הדגמת שק הריון שלא הודגם בו שק חלמון.
 - העדר דופק עוברי 11 ימים או יותר לאחר הדגמת שק הריון עם שק חלמון.
 - היעדר דופק עוברי בהריון שגילו 7.0 שבועות לפחות:
 - 3 שבועות או יותר לאחר בדיקת הריון חיובית (כמותית/ איכותית).
 - הריון IVF לפי חישוב גיל הריון.

בירור

- **שאלה:** האם יש צורך בבירור מיוחד לאחר הפלה
- **תשובה:** היות שמדובר באירוע שלא נוטה לחזור על עצמו, אין המלצה לבצע בירור מיוחד לאחר הפלה נדחית. במקרה של 3 הפלות אצל אותה המטופלת, מומלץ לבצע בירור של גורמים אחרים, כגון קרישיות יתר ומומים רחמיים. מומלץ להיוועץ ברופא המטפל או לפנות למרפאה המתמחה בטיפול בהפלות חוזרות.

דימום לאחר פרוצדורה

- **שאלה:** כמה זמן דימום נחשב תקין?
- **תשובה:** צפוי דימום משמעותי של כ-3-4 ימים לאחר נטילת הציטוטק ולאחר מכן ייתכן דימום קל אך ממושך למשך כשבועיים ולעיתים עד לוסת. הדימום הממושך הוא לרוב בכמות פחות מווסת. ייתכנו גם ימי הפסקה בדימום והישנות לאחר מכן במהלך פרק הזמן הזה.

תופעות לוואי

- **שאלה:** אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?
- **תשובה:** תופעות שכיחות: דימום המלווה בקרישי דם, כאבי בטן, התכווצויות, בחילות, לעיתים חום נמוך, רגישות בחזה, חולשה, גלי חום. תופעות חריגות המצריכות הערכה רפואית מיידי: חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד בלתי פוסק, דימום המצריך החלפת פד ספוג בתכיפות של מעל אחת לשעתיים, חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד יומיומי או סחרחורת משמעותית.

מתי לפנות לרופא

- **שאלה:** איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידית?
- **תשובה:** חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד בלתי פוסק, דימום המצריך החלפת פד ספוג בתכיפות של מעל אחת לשעתיים, חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד יומיומי או סחרחורת משמעותית, קושי בנשימה, כאבים שאינם מגיבים לתרופות לשיכוך כאב. איבוד הכרה.
- **שאלה:** אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון?
- **תשובה:** קיימות שתי אפשרויות לטיפול בהפלה נדחית: תרופתית וניתוחית. השיטה התרופתית ניתנת לביצוע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, וכוללת נטילת תרופות, מפיג'ין וציטוטק, המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות. הפסקת הריון ניתוחית נקראת גם גרידה או שאיבה. זוהי פעולה שמבוצעת בחדר ניתוח יום בהרדמה מלאה במהלכה נעשה שימוש במכשירים כירורגיים בהנחיית אולטרסאונד לרוקן את תוכן הרחם.

הגדרת הפסקת תרופתית

- **שאלה:** מהו טיפול תרופתי להפלה נדחית?
- **תשובה:** תהליך המבוצע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, כולל נטילת תרופות המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות.

ביקור ראשון

- **שאלה:** מה קורה בביקור הראשון?
- **תשובה:** מפגש עם רופא, סקירת רקע רפואי, וידוא שאין התוויות נגד, בליעת כדור מפיג'ין (mifepristone 200 mg). השגחה של 20 דקות וזיהוי של תגובה אלרגית במידה ומתפתחת.
- **שאלה:** באיזה מקרים לא ניתן לבצע טיפול תרופתי? מהן התוויות הנגד?
- **תשובה:** במקרים הבאים הרופא ימליץ לך להימנע מהפסקת הריון תרופתית: הריון מעל שבוע 12+0 על פי אולטרסאונד, אנמיה קשה (המוגלובין < 9), הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה, מחלת כבד פעילה, מחלה קרדיווסקולרית, אפילפסיה לא מאוזנת, אסטמה, חשד להריון חוץ-רחמי או הריון בצלקת של ניתוח קיסרי, אלרגיה לאחת התרופות שניתנות בטיפול, אי-יכולת לעמוד במעקב או הוראות טיפול.
- **שאלה:** כמה זמן נמשך הביקור? מה קורה בביקור הראשון בהרחבה?
- **תשובה:** בעת הגעתך למתחם מרפאות נשים בבית החולים וולפסון תתקבלי ע"י המזכירות ולאחר הצגת טופס 17 או פיקדון, הן יפתחו לך תיק ממוחשב ויוציאו מדבקות. עם המדבקות את תתקבלי ע"י האחות שתרכז את כל המסמכים ותבצע בדיקה של לחץ דם ודופק. האחות תעביר אותך לרופאה שתעבור על המסמכים, תמלא את הפרטים במחשב, תסביר על התהליך ולאחר מענה על שאלות תחתים אותך על טפסי הסכמה לתהליך המפרטים את התהליך, הסיכונים והסיבוכים האפשריים. בסיום המפגש תקבלי כדור מפיג'ין אותו עליך ליטול בחדר הרפואה ובנוסף תצויידי במעטפה בתוכה עוד ארבעה כדורי ציטוטק אותם יש להניח בנרתיק, בבית, כעבור 48 שעות. לאחר

נטילת הכדור במרפאה תתבקשי לחכות 20 דקות בחדר ההמתנה בהן תקבעי תור לביקורת במרפאה.

הכנות לביקור ראשון

- **שאלה:** מה להביא לביקור הראשון?
- **תשובה:** מכתב הפניה מהרופא אשר מתעד את האבחנה של הפלה נדחית, תוצאות בדיקות דם מהחודש האחרון כולל ספירת דם וסוג דם.

תופעות אחרי מפיג'ין

- **שאלה:** אילו תופעות צפויות אחרי נטילת מפיג'ין? אילו תופעות צפויות אחרי הביקור הראשון?
- **תשובה:** ברוב המקרים תחושי בחילה (לעיתים כמו בהריון צעיר), לעיתים דימום קל, כאבים קלים.

שלב שני: ציטוטק

- **שאלה:** מה השלב השני? מהו הטיפול בציטוטק?
- **תשובה:** בסיום המפגש הרופאה תצייד אותך במעטפה ובה ארבעה כדורי ציטוטק (Misoprostol) אותם תתבקשי להניח בנרתיק (עמוק ככל שניתן), בבית, כעבור 48 שעות ממועד נטילת המפיג'ין. כדורים אלה גורמים להתכווצויות רחם וריקון תוכן ההריון. בנוסף תיתכן חולשה, עליית חום קלה, צמרמורות, בחילות.

תרופות

- **שאלה:** האם יש ליטול את הטיפול עם או בלי אוכל?
- **תשובה:** אין חשיבות למועד נטילת התרופות, אין מניעה לקחת עם או בלי אוכל. במידה ואת מרגישה בחילות טרם תחילת הטיפול מומלץ ליטול כדור נגד בחילות שיכול להנתן לך במרפאה טרם הטיפול על מנת למנוע הקאה של הכדורים. יש להקפיד על הפרש של 48 שעות בין החלק הראשון של נטילת המפיג'ין לחלק השני של נטילת הציטוטק.
- **שאלה:** מהן תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי? מה השכיחות שלהן?
- **תשובה:** מפיג'ין: תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים. ציטוטק: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C , צמרמורות. שכיחות: בחילה (43%-66%), שלשול (23%-35%), כאב ראש (13%-40%), חום/צמרמורות (32%-69%).
- **שאלה:** מדוע הטיפול מורכב ממפיג'ין וציטוטק? חברה סיפרה לי שהיא קיבלה רק סוג אחד של כדור.
- **תשובה:** הטיפול מורכב גם ממפיג'ין (Mifepristone) ולא רק מציטוטק (Misoprostol) כי שילוב התרופות משפר משמעותית את יעילות ההפסקה התרופתית לעומת שימוש בציטוטק בלבד, ומפחית את שיעורי הכישלון והצורך בהתערבות ניתוחית. טיפול משולב הוא הסטנדרט במרבית מדינות ומרכזים רפואיים, ורק במקרים מסוימים יש אפשרות לשימוש בלעדי בציטוטק כאשר נחוץ. יתרונות השילוב: 1. שיעורי הצלחה של מעל 95%-98% להשלמת הפסקת ההריון בשבועות

המוקדמים. 2. פחות מקרים של המשך הריון/שאריית ברחם לעומת טיפול בציטוטק בלבד. 3. פחות צורך בכירורגיה משלימה (גרידה).

- **שאלה:** מה לעשות אם אין מפיג'ין? מה לעשות אם אני אלרגית למפיג'ין?
- **תשובה:** אפשרי להשתמש בציטוטק בלבד, אך יעילות ההליך יורדת (שיעור כישלון עולה לכ-10-15%).
- **שאלה:** מה זה מפיג'ין? מה תופעות הלוואי של מפיג'ין?
- **תשובה:** מפיג'ין (Mifepristone) הוא אנטי-פרוגסטרון החוסם את השפעת הפרוגסטרון ברחם, ההורמון החיוני להמשך ההריון. בכך המפיג'ין מחליש את רירית הרחם ומגביר את רגישות הרחם לפרוסטגלנדינים, כלומר מגביר את ההשפעה המרוקנת של ציטוטק. לאחר נטילת מפיג'ין ייתכנו תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים.
- **שאלה:** מה זה ציטוטק?
- **תשובה:** ציטוטק (Misoprostol) הוא פרוסטגלנדין שגורם להתכווצויות רחם ופינוי פיזי של תוכן ההריון. תופעות הלוואי של ציטוטק כוללות: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C , צמרמורות.

תופעות גופניות

- **שאלה:** מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?
- **תשובה:** נצפה לראות קרישי דם, וגושים הדומים ל"כבד" וכן נצפה לכאבים חזקים והתכווצויות בבטן תחתונה. רוב הנשים מתארות כאבים אלו ככאבים משמעותיים יותר מכאבי מחזור.
- **שאלה:** האם חום נמוך הוא תופעה שכיחה?
- **תשובה:** חום נמוך הוא תופעה יחסית שכיחה המופיעה אצל 30%-70% מהמטופלות. במידה ומדובר בחום מעל 39 מעלות או חום שאינו מגיב לתרופות להורדת חום – יש לפנות לבדיקת רופא זמינה במייד.

שלב הדימום

- **שאלה:** האם יש הבדל בין דימום רציף לדימום שבא והולך? האם הדימום אמור להיעלם בהדרגה או בפתאומיות?
- **תשובה:** הדימום יכול להיות דימום רציף וממושך למשך מספר ימים, ולחילופין הדימום יכול להיעצר ולהתחדש אחרי מספר שעות/ימים. כל עוד לא מדובר בדימום זורם כמו "ברז" או צורך בהחלפת מעל פד בשעתיים – מדובר בדימום תקין.
- **שאלה:** האם קרישי דם הם תמיד חלק מההליך?
- **תשובה:** אצל כל אישה דימום הוא בעל אופי שונה. אצל מרבית הנשים נצפה לראות קרישי דם או רקמה הריונית הנפלטת במהלך התהליך, אך ייתכן תהליך תקין גם ללא יציאה של קרישי דם.

תחילת התהליך

- **שאלה:** ממתי לקחת ימי מחלה? מתי הכל יתחיל? מתי יתחיל החלק העיקרי של התהליך?

- **תשובה:** אצל מרבית הנשים התהליך הכולל דימום משמעותי וכאבים עזים יתחיל לאחר נטילת כדורי הציטוטק בבית. לרוב נצפה לתגובה תוך חצי שעה ועד ליממה. ייתכנו מקרים בהם התגובה תתחיל כבר לאחר נטילת המפיג'ין במרפאה או לחילופין מקרים בהם התגובה מתחילה רק במהלך השבוע שלאחר נטילת הציטוטק.

משך ההחלמה

- **שאלה:** כמה זמן לא מרגישים טוב? ומה קורה אחר-כך? כמה זמן נמשך השלב הלא נוח?
- **תשובה:** בדרך כלל מדובר על 3-4 ימים של אי נוחות, כאבים עזים ודימום משמעותי. אחר כך רוב הנשים חוות הטבה משמעותית, אך דימום קל וכאבים יכולים להימשך עד שבועיים ולעיתים עד הוסת.

משככי כאבים

- **שאלה:** האם מותר לקחת משככי כאבים? האם מותר לשלב בין משככי כאבים?
- **תשובה:** כן, כל משכך כאבים שעוזר בזמן מחזור מתאים גם כאן (לדוגמה: נורופן, אדוויל, אקמול, אופטלגין). יש להקפיד על הוראות רוקח.
- **שאלה:** האם מומלץ לקחת משככי כאבים לפני תחילת הטיפול או רק כשמופיעים הכאבים?
- **תשובה:** ניתן לקחת משככי כאבים כהכנה, אך הדבר תלוי בהעדפתך. חלק מהנשים מעדיפות לחכות עד שמתחילים הכאבים ואז ליטול משכך. בכל מקרה, חשוב שיהיו משככי כאבים זמינים למקרה הצורך, ותמיד להקפיד על המינון והנחיות הרוקח.

ביקורת

- **שאלה:** איך אדע שהטיפול הצליח? האם נדרש מעקב? איך אני עושה ביקורת?
- **תשובה:** בעת סיום הביקור הראשון נתאם לך תור לביקורת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק. במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד בגישה נרתיקית לוודא שהרחם התרוקן ואין שאריות הריון. אם יש שארית ברחם – יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק, או גרידה ניתוחית, על פי רצונך והמלצת הרופא).

ביקורת שנייה

- **שאלה:** מה קורה בביקורת השנייה?
- **תשובה:** במידה וקיבלת מנה נוספת של ציטוטק, תוזמני לביקור נוספת כעבור שבוע. במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד בגישה נרתיקית לוודא שהרחם התרוקן ואין שאריות הריון. אם יש שארית ברחם – ההמלצה תהיה לבצע גרידה.

מהלך הטיפול

- **שאלה:** האם ישנן הגבלות בזמן הטיפול? מהן? לכמה זמן?

- **תשובה:** במהלך הטיפול אנו ממליצים להימנע מקיום יחסי מין, כניסה לים ולבריכה, פעילות גופנית מאומצת ושתיית אלכוהול. עם סיום דימום ותחושת רווחה ניתן לחזור לפעילות שגרתית, לרוב תוך 3-4 ימים לאחר ציטוטק. לפעילות הכוללת כניסה לים/בריכה וקיום יחסים יש להמתין עד להשלמת הביקורת כעבור שבועיים.